جمهورية العراق
وزارة الصحة والبيئة
دائرة الصحة العامة

كراس الصحة النفسية للفئات العمرية الأكثر عرضة للاضطرابات النفسية

كراس تدريبي مخصص للملاكات الطبية والصحية العاملة في الرعاية الصحية الاولية









اعداد
د. رياض الرديني
رئيس اطباء اختصاص
مدير شعبة الصحة النفسية
٢٠١٩

الفصل الاول

مفاهيم الصحة النفسية:

حسب تعريف منظمة الصحة العالمية فان الصحة هي ليست الخلو من المرض او العجز وانما هي حالة من العافية التامة البدنية والنفسية والاجتماعية, أذا فالصحة النفسية والاجتماعية هما ركنان اساسيان من اركان الصحة ,

والصحة النفسية هي ايضا ليست الخلو من المرض النفسي. او العجز الذي يسببه بل هي حالة من العافية التي يستطيع فيها كل فرد ادراك امكاناته الخاصة والتكيف مع مصادر الاجهادات العادية في الحياة، والعمل على نحو منتج ومثمر والإسهام الايجابي في مجتمعه.

لذلك يمتلك الاشخاص الاصحاء نفسيا ادوات للتعامل والتركيز والمرونة والابداع في الاوقات العصيبة والاوقات الجيدة على السواء ويشعورون بالراحة والثقة والاعتزاز بالنفس والحفاظ على نظرة ايجابية للحياة والعمل باداء وانجاز افضل والتواصل الايجابي مع الاخرين.

لذلك لاتقل الصحة النفسية اهمية عن الصحة البدنية في تكوين العافية الاجمالية للافراد والاسر والمجتمعات المحلية والمجتمع ككل.

تؤثر الصحة النفسية على جميع البلدان وجميع المجتمعات والاغنياء والفقراء, والمناطق الحضرية والريفية, والافراد من جميع الثقافات والاعراق والاجناس والاعمار. فالصحة النفسية الجيدة عامل اساسي لجودة حياة الافراد واسرهم ولتحقيق النجاح الاجتماعي واقتصادي وضمان مستقبل امن للمجتمعات والامم.

الاعتقاد الخاطئ هو ان المرض النفسي يحدث جراء اقتراف معاصي او سحر او مس من الجن
والحقيقة ان معظم الامراض النفسية تحدث نتيجة تفاعل معقد لمجموعة من العوامل البيولوجية والنفسية والاجتماعية

ان محددات الصحة النفسية عديدة وتشمل صفات الإنسان الفردية (قدرته على إدارة أفكاره وعواطفه وسلوكياته وتفاعلاته مع الآخرين)، اضافة الى عوامل صحية واجتماعية وثقافية واقتصادية وسياسية وبيئية تحيط به مثل سلامة الصحة البدنية, الدفء العائلي وتماسك الاسر, التنشئة الاجتماعية, التربية والتعليم السليمين, الضمان الاجتماعي ومستويات المعيشة, شبكات الدعم الاجتماعي, الموروثات الثقافية والاجتماعية السائدة, وحماية حقوق الانسان, ويحدث المرض النفسي نتيجة تفاعل معقد بين تلك العوامل.

الاعتقاد الخاطئ ان الامراض النفسية تصيب الاخرين فقط ولا تصيبنا,
والحقيقة ان الامراض النفسية قد تصيب اي شخص

الاضطراب النفسي- هو مصطلح يستخدم لوصف الامراض النفسية الرئيسية (القلق, الاكتئاب, الفصام, الاضطراب الوجداني ثنائي القطب) ومجموعة الاضطرابات الاخرى التي يمكن تشخيصها بما في ذلك اضطرابات السلوك, اضطرابات الشخصية, اضطرابات النوم والاكل, الاضطرابات النفسية الجنسية, الاضطرابات النفسية المتعلقة بتعاطي الكحول وسوء استخدام المواد, صعوبات التعلم واضطراب طيف التوحد وغيرها, وقد تكون حادة او تستمر لفتره طويلة وتختلف في شدتها, وهي تظهر باعمار مختلفة. تشير ابحاث ودراسات دولية ومحلية الى ان المشاكل الصحية النفسية شائعة ويتاثر بها اكثر من واحد من كل اربعة اشخاص في اي لحظة من الزمن بالاضافة الى ان اعباء الصحة النفسية في الصحة العامة تشكل المرتبة الثانية عالميا بعد امراض القلب والشرايين.

الفئات الاكثر عرضة للاضطرابات النفسية تشمل:

- الرضع والأطفال الذين يتعرضون لسوء المعاملة والإهمال.
- اليافعين المعرضين للمرة الأولى لتعاطي الكحول والمواد الادمانية.
- المراة نتيجة للتهميش وفقر والعنف المنزلي وفرط العمل والإجهاد من الشواغل المتنامية.
- المسنين والأشخاص المصابين بحالات صحية مزمنة.
- السجناء والأقليات والأشخاص الذين يتعرضون للتمييز وانتهاكات حقوق الإنسان والعنف.
- افراد المجتمع الذين تعرضوا الى الشدائد والمحن الانسانية.
- فئة الشباب العاطلين عن العمل.
- افراد الأسر التي تعاني من الفقر.

من الافكار المغلوطة والشائعة هي ان الاضطرابات النفسية لاتصيب الاطفال
والحقيقة ان الاطفال ايضا قد يصابون بالاضطرابات النفسية وحتى في اعمار مبكرة

أثار تدهور الصحة النفسية: يمكن لتدهور الصحة النفسية ان يترك اثار متعددة على صحة الفرد الجسدية ونوعية حياته وسلامته. ولاتقتصر هذه الاثار على الفرد وحده بل تتعداه الى اسرته ايضا. فالمرض النفسي يزيد من مخاطر تعرض الاشخاص الى الاصابة بامراض جسدية كالسرطان والسكري والتهاب المفاصل وامراض القلب والجهاز العصبي, علاوة على ذلك يمكن ان يؤدي وجود مرض جسدي مرافق لاضطراب نفسي الى تفاقم كلتا الحالتين الجسدية والنفسية وتاخر الشفاء, كذلك يمكن ان يكون تدهور الصحة النفسية سببا ونتيجة لامراض جسدية.

يواجه الافراد الذين يعانون من مشاكل نفسية صعوبات ايضا في ممارسة الانشطة اليومية كالتعليم والعمل والانشطة الترفيهية والحفاظ على العلاقات الاجتماعية. وتواجه عائلات الاشخاص الذين يعانون من مشاكل نفسية صعوبات مرتبطة بادارة المطالب العاطفية للرعاية, والتي يمكن ان تزيد من خطر تمرض افراد تلك الاسر ومقدمي الرعاية انفسهم لمشاكل نفسية. وهناك اثار اخرى على الاسر منها الوصمة الاجتماعية للاضطرابات النفسية وتعطل روتين حياة المنزل والتعامل مع سلوك الاقارب وفرض قيود على الانشطة الاجتماعية وصعوبات اقتصادية مرتبطة بتعطيل العمل.

الاعتقاد الخاطئ انه من الافضل عزل المصابين بأمراض نفسية عن باقي افراد المجتمع
والحقيقة ان الغالبية العظمى من المصابين بامراض نفسية يحققون نتائج افضل
عندما يعيشون ويتلقون العلاج في مجتمعهم

الرعاية الصحية النفسية الاولية: تلعب الرعاية الصحية الاولية دورا متنامياً في معالجة الاضطرابات النفسية وستشكل حجر الاساس لنظام تقديم خدمات الصحة النفسية المستقبلي حيث توفر الرعاية الصحية الاولية في معظم الحالات نقطة الاتصال الاولى لمستخدمي الخدمات وعائلاتهم, وتدعم منظمة الصحة العالمية هذا النهج وتدعوا الى ضرورة ادماج الرعاية الصحية النفسية في الرعاية الصحية الاولية بهدف الحد من الوصمة وتحسين فعالية التكلفة وتحقيق نتائج علاجية افضل.

تشير البيانات العالمية الى ان ٩٠% من الاضطرابات النفسية مصنفة ضمن الفئات الخفيفة الى المعتدلة بينما تصنف بنحو ١٠% منها على انها خطيرة بطبيعتها, وهذه البيانات تعزز خيار التركيز بشان تقديم خدمات الصحة النفسية في مراكز رعاية صحية اولية ومراكز رعاية مجتمعية

أثر الوصمة:

تنشأ الوصمة من المواقف السلبية حيال المرض النفسي وسوء فهمه وهي تشكل عائقا امام تطور الرعاية الصحية النفسية وجودة الحياة في جميع انحاء العالم.

تشير الدلائل الى وجود كثير من افراد المجتمع يواجهون مشاكل نفسية الا انهم لايتحدثون عن مشكلاتهم علنا وان الخجل والخوف من الوصمة وقلة الموارد المادية لديهم تمنع الافراد وعائلاتهم من التحدث علنا عن المرض النفسي, ومن السعي الى العلاج والدعم, وقد سبب هذا قدرا كبيرا من المعاناة الفردية واثارا اجتماعية واقتصادية واسعة النطاق على الصحة والانتاجية.

تتتسبب الوصمة احيانا في حرمان الافراد الذين يعانون من امراض نفسية من التعليم والعمل والعلاقات الاجتماعية. وقد عانى الكثير من الناس من الاثار السلبية المرتبطة بالمرض النفسي. بما في ذلك انخفاض احتمالات الزواج وفرص العمل, وكذلك العزلة الاجتماعية.

الاعتقاد الخاطئ بان علاج الامراض النفسية ليس بأيدي الأطباء، لأن سببها هو التلبس بالجن أو الحسد أو السحر! والحقيقة هي تجب معالجة المريض النفسي بأيدي الأطباء المختصين كما في معالجة أي مرض بدني

علامات تمتع الفرد بالصحة النفسية:

١. معرفة القدرات والامكانات الحقيقية للذات والسعي للأستفادة منها وتطويرها، ومعرفة السلبيات الذاتية والاعتراف بها والعمل على تجاوزها.
٢. القدرة على التعامل السليم مع ضغوط الحياة المعتادة ومواجهتها وحل المشاكل اليومية بشكل إيجابي، وباعتدال بعيداً عن الانفعالات المبالغ فيها والتصرفات السلبية والتهور.
٣. القدرة على إقامة علاقات اجتماعية سليمة مع الآخرين وإدامة تلك العلاقات.
٤. القدرة على العمل والإنتاج المثمر وعلى العطاء لتطوير نفسه وعائلته ومجتمعه.
٥. (السلوان) هي المرونة والثبات أمام الأزمات والقدرة على مداواة الذات وتجاوز الأزمات النفسية.

العناصر الاساسية للنمو النفسي السليم

- ❑ الجسم السليم
- ❑ الدفء العائلي
- ❑ التربية والتعليم المناسبين: (تعلم العلم والقيم والمعتقدات السليمة)

المرض النفسي: لفهم معنى المرض النفسي لابد أولاً معرفة ألابعاد الثلاثة للحالة النفسية لأي فرد، والمتمثلة بالأفكار، المشاعر، والسلوك والاداء الوظيفي والمجتمعي ومن خلالها يمكننا ان نقييم الحالة الصحية او المرضية للفرد.

١. **الأفكار**: وهي ما يدور في ذهن الفرد من أمور وآراء أو قرارات أو خطط ولايعرفها إلا الشخص نفسه ولانستطيع معرفتها إلا إذا أخبرنا هو بها، وقد نستدل عليها من تصرفاته.
٢. **المشاعر**: ويقصد بها مايشعر به الفرد من عواطف كالحب، الغيرة، الكره، الغضب ومما يعتري المرء من إنفعال تجاه شخص ما أوموضوع ما أوموقف ما ونحن عادة لا نعرف مشاعر الآخرين إلا مما يظهر عليهم من تعابير أو من كلامهم وتصرفاتهم الأخرى.
٣. **التصرفات (السلوك)**: هي يقوم به الفرد من أعمال وحركات وأقوال ويمكن الاحساس بها. فأننا كأفراد في المجتمع لا نرى من الآخرين إلا تصرفاتهم أما أفكارهم ومشاعرهم فنستدل عليها من تصرفاته بالإستناد إلى المعايير المتعارف عليها في مجتمعنا.

من هو الفرد الذي نعتقد أنه مريض (مضطرب) نفسياً؟

أن الشخص قد يكون مصاباً باضطراب نفسي. إذا كانت لديه خلل في ألافكار أو المشاعر أو السلوك وتكون مزعجة له أو للآخرين مع تردي في الاداء الوظيفي والمجتمعي.



أسباب الاضطرابات النفسية:

١. **عوامل ممهدة:**

أ- الاستعداد الوراثي (وجود عامل وراثي لدى العائلة).

ب- المرحلة الجنينية من حياة الطفل وما تعرضت له الام من امراض او شدة او اشعاع او عقاقير اثناء الحمل.

ت- التعرض للشدة اثناء الوضع (الولادة).

ث- السمات الشخصية الفرد والعوامل النفسية والاجتماعية التي تعرض لها في بداية حياته. (مثال: اليتم، التشرد، الأعتداء الجنسي،..)

٢. **عوامل مرسبة:**

والتي تحدث قبل ظهورالاضطراب النفسي مباشرة وتؤدي الى ظهور النوبة المرضية وهي:

أ- الامراض العضوية والعقاقير

ب- الشدة النفسية (الكروب)

ت- الأزمات الاقتصادية والمتغيرات الاجتماعية

٣. **عوامل تديم الاضطراب النفسي:**

أ- الاضطراب النفسي. نفسه: فمثلاً في حالة الرهاب يتجنب المريض الشيء الذي يرهبه كالطائرة مثلا وهذا التجنب المستمر بذاته يديم الاضطراب ويزيد من شدته.

ب- العوامل الاجتماعية كموقف الاهل والاقارب من المريض او المعلم او الاخرين منه.

ت- المرض المزمن او العاهة.

تصنف الاضطرابات النفسية بصورة مبسطة الى:

١. **الاضطرابات النفسية العصابية** (Neurosis)

المريض هنا يعاني ويشعر بمعاناته النفسية، ويكون مستبصراً بمشكلته وهي:

- اضطرابات القلق الرهابي.
- اضطراب الوسواس القهري.
- اضطراب الاستجابة للكرب الشديد.
- الاضطرابات الانشقاقية (التحولية).
- اضطرابات جسدية الشكل.

٢. **الاضطرابات النفسية الذهانية** (Psychosis)

المريض هنا لا يعاني ولا يشعر بمعاناته النفسية وغير مستبصر بحالته ويرى أنه سليم حيث يعاني من حولَه بسبب سلوكه وأفكاره.

فقدان البصيرة هي العلامة الفارقة مابين الاضطراب الذهاني والعصابي, وكذلك وجود هلاوس واوهام.

٣. اضطرابات نفسية أخرى

- الاضطرابات النفسية المتعلقة بتعاطي المخدرات
- اضطرابات الشخصية
- اضطرابات النوم والأكل
- الاضطرابات النفسية الجنسية
- التخلف العقلي

تهدف الصحة النفسية الاولية تطبيقيًا إلى:

١. الوقاية من الاضطرابات النفسية حيث نعمل على تحديد الجوانب التي يمكن أن تسبب الاضطرابات، ثم نعمل على إزالتها وإبعاد الأفراد عنها مع توفير الشروط العامة التي تعطي الفرد قوة عملية لمواجهة الظروف الصعبة.

٢. الاكتشاف المبكر وتدبير الاضطرابات النفسية الشائعة والمحافظة على استمرار الصحة والتكيف الأفضل مع ظروف الحياة المختلفة.



الفصل الثاني

الصحة النفسية للاطفال:

- **ماهو تعريف الطفل:** الطفلِ هو كل إنسان دون سن الثامنة عشرة من العمر (الاتفاقيَّة الدوليَّة لحقوق الطفل).
- **الاتفاقيّة الدولية لحقوق الطّفل:** هي اتفاقيّة أقرّتها الجمعيّة العامّة للأُمَم المتّحدة عام ١٩٥٩م. والتي تنُصّ على حماية الأطفال وحقوقهم بشكلٍ غير قابلٍ للتّفاوض. اعتمدت هذه الاتّفاقيّة بالإجماع في ٢٠/ ١١ /١٩٨٩م.
- **اهم حقوق الطفل هي:**
  - **حق الحياة** (الحق في البقاء على قيد الحياة منذ لحظة ولادته)
  - **حق التعليم** (الحق في الوصول الى سبل التعليم دون تمييز)
  - **حق المياه والغذاء** (الحق في الحصول على ماء وغذاء صحي بشكل كافي ويومي ومستمر وفي كل الظروف)
  - **حق الصحة** (الحق في الحصول على جميع الخدمات الصحيّة ومنها التّطعيمات اللازمة للحفاظ على صحّة الطّفل الجسديّة، والعقليّة، والنفسيّة)
  - **حق الهوية** (حق حصول كلّ طفل على اسم، واسم عائلة، وتاريخ ميلاد، وجنس، وجنسيّة تُمكّن الطفل من التمتُّع بالحقوق التي تتناسب مع عمره، وبالخدمات التي تُقدّمها الدّولة، والانتماء إلى أبويه وعائلته)
  - **حق الحرية** (حقّ الطّفل في التمتُّع بأنواع الحُريّات المُعطاة للبالغين كلّها؛ فمِن حقّ الطّفل التمتُّع بحريّة التّفكير، وحريّة التّعبير عن أفكاره، والحقّ في معرفة ما يجري حوله والاطّلاع، وحريّة تكوين التجمُّعات، والاشتراك في النّقاشات الجماعيّة، والمُشارَكة في مُجتَمعات ذات أهداف مُحدَّدة، وحريّة تبنّي الأفكار والقَناعات التي يُفضّلها الطّفل، وحريّة فلسفته في الحياة، وحريّة اختيار الدّيانة التي يُريدها الطّفل)
  - **حق الحماية** (الحق في حمايته جسديّاً، وحماية صحّته ونموّه، وحمايته نفسيّاً وعقليّاً، وحماية حقوقه, والقرارات التي يتمّ اتّخاذها يجب أن تَأخُذ بعين الاعتبار المصلحة العُليا للطّفل ومستقبله، والقرارات التي يتمّ اتخاذها نيابةً عنه يجب أن تضمن حصوله على حقوقه)

مراحل النمو للطفل

١) الاخصاب
٢) الجنين
٣) الولادة
٤) مرحلة مابعد الولادة والطفولة
   السنة الاولى
   السنة الثانية
   السنة الثالثة – السنة الخامسة
   السنة السادسة – السنة الحادية عشر
٥) مرحلة المراهقة (١١-١٣ للاناث, ١٣-١٧ للذكور)

مرحلة الإخصاب

- تبدأ رحلة الحياة بالتقاء حيمن الرجل مع بويضة المرأة حيث يتم الإخصاب في قناة فالوب لتتكون البيضة المخصبة التي تنقسم عدة مرات حتى تصبح كرة صغيرة تنزل الى الرحم لتكوين المشيمة والجنين.
- وجود أي خلل في حيمن الرجل أو بويضة المرأة قد يسبب اضطراباً نفسياً أو جسدياً لدى الطفل
- تبرز أهمية اجراء الفحص والمشاورة الطبية قبل الزواج والحمل.
- ينصح بتجنب زواج الأقارب عند وجود مرض وراثي
- ينصح بالإجراءات اللازمة عند عدم تطابق دم الزوجين (عامل Rh) وبأنه ليس مانعا للزواج
- يبين أن زيادة عمر الأبوين ترافقها زيادة ملحوظة في احتمال ولادة طفل منغولي.

- اكتشاف بعض الأمورقبل الزواج والحمل، مثل الاصابة بفيروس التهاب الكبد الفيروسي أو فيروس نقص المناعة المكتسب أو الأخماج المنقولة جنسياً لغرض اتخاذ اللازم بشأنها من أمور التوعية والوقاية والمعالجة.
- ان الحمل المرفوض (الطفل الغلطة) يؤثر سلبياً في حياة الطفل مستقبلاً بشكل أو بآخر رغم حب الأم له بعد ولادته ورعايتها له فمن الضروري جداً ان يكون الأبوان راغبين فعلاً بالحمل وبالطفل المنتظر.

مرحلة الحمل (المرحلة الجنينية)

- في هذه المرحلة تتجلى أهمية الفحص الدوري للحامل لمتابعة الحالة الصحية والتغذوية لها وللجنين والإكتشاف المبكر لعوامل الخطورة والتصرف أزاءها.
- أضافة لتقديم النصح والإرشاد للحامل، فهناك عوامل عديدة قد تتعرض لها الحامل وتؤثرفي مستقبل الطفل المنتظر ومنها مثلاً:
  - ✓ تناول الأدوية.
  - ✓ التعرض للإشعاعات الضارة.
  - ✓ الإصابة بالأمراض المختلفة (كالحصبة الألمانية، السفلس، الأيدز...الخ).
  - ✓ مشاكل عدم تطابق الدم بين الأم والجنين.
  - ✓ مشاكل سوء التغذية وخاصة نقص اليود،الفولك أسيد... الخ.

مرحلة الولادة

إن تعرض الطفل

- لقلة الأوكسجين،
- تأخر الولادة وتعسرها،
- أية شدة على الرأس قد تسبب ضرراً في الدماغ،

وكل هذه عوامل قد تسبب أضراراً نفسية وعصبية مستديمة ان لم تسبب الوفاة. لذا لابد ان تتم الولادة بمساعدة أيد أمينة ماهرة متدربة على التعامل مع كل الإحتمالات أثناء الولادة؛ مما يستوجب التخطيط المسبق والتهيئة لمكان الولادة ومن سيساعد في عملية الولادة.

مرحلة مابعد الولادة والطفولة

بعد الولادة يأتي كائن جديد منفصل جسدياً عن أمه ومزود بوسائل تساعده أن يشق طريقه في الحياة. فهو قادر على التنفس، المص، البلع، التغوط، التبول، البكاء، التحسس بالظروف المحيطة به. حين يولد الطفل يكون حجم دماغه حوالي ثلثي حجم الدماغ الناضج وينمو ويكبر بسرعة خلال السنتين الأوليتين من العمر.

- إن توفر الغذاء المناسب ضروري جداً لهذا النمو مما يستوجب الإلتزام **بالرضاعة الطبيعية** التي توفر الغذاء الأنسب وتعطي الإحساس بالأمان والطمأنينة والثقة للطفل،
- كما يستوجب توعية الأمهات بانواع **الأغذية التكميلية** التي يجب اعطاؤها للطفل والعمر الذي تعطى فيه للطفل.

وندرج فيما يلي بإيجاز السمات العامة للمراحل العمرية:

السنة الاولى من العمر:

العمر	نوع النمو
شهرين	يبدأ الطفل بالإبتسام مما يفرح والديه كثيراً.
٣ – ٤ أشهر	يميز والديه ويبتسم لهما، ولايستغرب من الأخرين.
سبعة أشهر	يبدأ بالإستجابة عند مناداته بإسمه.
ثمانية أشهر	الخوف والتوجس والبكاء من الغرباء.
تسعة أشهر	يبدأ بتقليد التصرفات الجديدة.
عشرة أشهر	القلق والبكاء عند ابتعاد الأم أو عند تركه مع الأخرين.

اثني عشر شهراً علاقة وطيدة مع الأم والآخرين في الأسرة، انتظام أوقات النوم والأكل، يتعلم تمييز الأشياء في بيئته تدريجياً ويكون علاقات سببية بين الأشياء والظواهر حوله، ويتمكن من نطق بعض الكلمات مثل بابا، ماما، دادا ويستمتع بذلك.

السنة الثانية من العمر:

- يبدو وكأنه يرغب بإرضاء والديه ويقلق اذا أحس بزعلهم.
- يتعلم السيطرة على سلوكه تدريجياً وحسب ماتقتضيه المواقف المختلفة.
- تتوطد علاقته اكثر مع الأبوين والأسرة من حوله والذين يهتمون به وبرعايته.
- نوبات انفعال عصبية وبكاء عند تقييد رغباته أو حركته أو فضوله في استطلاع الأشياء حوله.
- يقل الخوف من الغرباء ويبدأ الخوف من بعض الحيوانات كالكلاب.

في نهاية السنة يستطيع تشكيل جملة من كلمتين أو ثلاثة.

السنوات الثالثة – الخامسة من العمر (سنوات الروضة والتمهيدي)

- نمو كبير وسريع في الذكاء والقدرات العقلية والمعرفية وخاصة القدرة على الكلام من فهم وتعبير.
- نمو إجتماعي واضح، تقليد الآخرين في سلوكهم وتقمص طبائع وتقاليد وقيم الأبوين (بداية مرحلة تكوين الضمير وإكتساب القيم وهنا تبدو أهمية تصرف الأبوين كقدوة حسنة أمام أطفالهم).
- تكوين علاقات ودية مع الأخوة والأخوات في الأسرة ومع الأخرين.
- تستمر نوبات الإنفعال والعصبية والتوتر ولكنها تقل وتختفي نهاية العام الخامس.
- تبرز كثيراً ظاهرة الفضول وحب الإستطلاع وكثرة الأسئلة.
- ينمو لديه الخيال الذي يشبع رغباته التي لا يستطيع إشباعها في الواقع ويستمتع ببعض اللعب والأشياء.
- يبدأ بتمييز هويته الجنسية كذكر أو أنثى وتمييز جنس الآخرين. كما يهتم بأعضائه الجنسية ويداعبها.
- يزداد الخوف من الحيوانات في البداية ولكن مع الوقت يتغير نحو الخوف من الأخطار الخيالية كالإشباح والوحوش.
- تشمل مشاكل هذه الفترة صعوبات وإضطرابات الأكل والنوم والتعلقبالأبوين والقلق عند إبتعادهم والإنفعال الشديد عند الإحباط في الحصول على ما يريد وقد تصل حد العدوانية.

عمر السادسة – أحد عشر عاماً (عمر المدرسة)

- يستطيع تمييز هويته الجنسية ومكانه في الأسرة.
- التأقلم مع محيط المدرسة وتعلم القراءة والكتابة والحساب.
- التعامل مع المعلم والمعلمة كشخصية مهمة في حياته.
- يدرك ما يستطيع فعله وما لا يستطيع فعله .
- يفضل اللعب الجماعي والإختلاط مع أطفال من جنسه (الولد مع الأولاد والبنت مع البنات).
- الخوف من الأخطار الخيالية موجود ولكن الطفل يبدأ بالخوف من الموت والتفكير في معناه، وبعض الأطفال تسيطر عليهم فكرةالخوف من فقدان الأبوين مبكراً.
- من أهم المشاكل في هذه المرحلة: الخوف، القلق، كوابيس النوم، بعض العلاقات المضطربة مع أقرانه، عدم الطاعة في بعض الأحيان والمشاجرات مع الآخرين.

ان النمو النفسي الطبيعي يحتاج الى:

- الصحة البدنية، التغذية الجيدة، الوقاية من الأمراض المعدية (لذا يجب الإلتزام بإكمال التلقيحات) والإكتشاف المبكر والمعالجة السريعة لأي مرض قد يؤثر في نمو الطفل مثل الفينايل كيتون يوريا، قصور الغدة الدرقية...الخ. وهذا يبين أهمية إجراء فحوص الغربلة للأمراض الأيضية.
- كما يتطلب ايضاً وجود المؤثرات الخارجية المحفزة لقدرات الطفل كالتحدث معه وملاعبته وابعاده عن مصادر الأذى والإزعاج، التواصل معه، ضمه إلى الصدر، إلخ. ومن المهم أن نذكر هنا ان الطفل ليس كائناً سلبياً متلقياً فقط بل هو كائن ايجابي يتفاعل بطريقته الخاصة مع البيئة المحيطة به أثناء نموه حتى يكبر ويكون له الشكل النفسي الخاص به.

- وثمة حقيقة مهمة لابد من معرفتها وتعليمها لكل الأباء والأمهات وهي ان الأطفال الأصحاء نفسياً عادة يأتون من عوائل ودودة متحابة والتي يسودها الدفء والإحترام المتبادل بين افرادها مهما كان النمط التربوي الذي تتبعه العائلة.

فترة المراهقة

هي مرحلة النمو التي تتوسط بين الطفولة والنضج وتبدأ عادة بالبلوغ الجسدي الذي يبدأ بعمر ١١-١٣ سنة للأناث و ١٣-١٧ سنة للذكور. ويحصل في هذه الفترة نمو جسماني كبير وسريع وخاصة بالأعضاء التناسلية كما تتجلى المظاهر الجنسية الأخرى مثل غزارة الشعر وتوزيعه، تغير الصوت، زيادة الافرازات الدهنية وظهور حب الشباب، الخ. ويرافق ذلك تغيرات نفسية ملحوظة منها:

- إدراك الفرد المتزايد لشخصيته وللفروقات الفردية التي تميزه عن الآخرين بحيث يعرف من هو أو من هي والى ماذا يصبو.
- نمو العلاقات القوية بشلة الأقران التي تنمي لديه روح إستقلال الذات والإعتماد على النفس.
- الإهتمام بالجنس الآخر والتودد اليه ونمو الرغبة الجنسية تجاهه.
- من أهم مشاكل هذه الفترة: الحساسية المفرطة والمزاجية، القلق، النفور من المدرسة عند البعض، صعوبة إقامة وإدامة العلاقات مع شلة الأقران أحياناً، عدم الطاعة، التمرد، وفي بعض الأحيان الجنوح السلوكي (كالسرقة، العدوانية، المشاجرة، الهروب من البيت أو المدرسة، سوء إستخدام العقاقير والمواد الأخرى،الخ).

نؤكد على أهمية وتأثير أسلوب التعامل السليم مع الطفل في مراحل نموه كلها وضرورة إدامة العلاقة الودية بينه وبين مقدمي الرعاية له (الأبوان أو غيرهما) والإعتدالفي الإهتمام به وعدم الإفراط بالقلق عليه، والإستجابة الودية لإحتياجاتهالأساسية ورغباته المشروعة، والإبتعادعن العنف في تربيته، والتصرف كقدوة حسنة صادقة أمامه. كل ذلك سيؤدي به الى نمو نفسي سليم ويحصنه ضدالإضطراب النفسي مستقبلاً بإذن الله.

عوامل الخطورة على نمو الطفل:

١. سوء التغذية، فقر الدم
٢. نقص اليود
٣. الاختناق ما حول الولادة
٤. قلة وزن الوليد
٥. الأخماج
٦. الفقر
٧. الجهل عامة وبتنشئة الطفل خاصة
٨. ضعف الدعم العائلي والاجتماعي
٩. الاضطراب النفسي لمربي الطفل
١٠. تلوث البيئة
١١. اليتم
١٢. سوء الظروف المدرسية
١٣. الهجرة من الريف للمدن الكبيرة

لماذا الاهتمام بالنمو النفسي للطفل؟

- لمعرفة أحسن الوسائل الممكنة للحفاظ على الصحة النفسية للطفل
- الوقاية من الإنحرافات والإضطرابات النفسية
- الإكتشاف المبكر لأي منها بهدف التعامل الصحيح معها
- الوصول الى أفضل المستويات الممكنة من الحياة السوية الصحية

أفكار مغلوطة شائعة والحقائق العلمية

١. **الأضطرابات النفسية لا تصيب الأطفال!**
الحقيقة: الأطفال يصابون بالأضطرابات النفسية وحتى في أعمار مبكرة.

٢. **ان الاضطرابات النفسية كلها لا تشفى!**
الحقيقة: الاضطرابات النفسية تشابه الأمراض البدنية، بعضها يُشفى تماماً وبعضها مُزمن ويستوجب معالجة مستمرة للسيطرة عليها.

٣. **علاج الاضطرابات النفسية ليس بأيدي الأطباء والمختصين، لأن سببها هو التلبس بالجن أو الحسد أو السحر!**
الحقيقة: يتوجب معالجة المريض النفسي بأيدي الأطباء والمختصين كما في معالجة أي مرض بدني؛ ولايجوز شرعا أوقانونا أوعلمياً حرمان المريض من العلاجات الطبية التي ثبتت فائدتها للسيطرة على هذه الأمراض.

الوصايا الأساسية للتربية النفسية السليمة

- الاكتشاف المبكر لأي خلل في سمع الطفل أو بصره يساعد في نجاح علاجه ويؤمن نمواً نفسياً واجتماعياً له.
- الضرب والعقاب الجسدي لايقوم سلوك الطفل بل يعلمه العدوانية وايذاء الاخرين عند الكبر.
- احترام الطفل وخاصة أمام أقرانه يعطيه الثقة بنفسه ويعلمه احترام الآخرين.
- الجسم السليم مع عائلة مستقرة مع التربية والتعليم الصحيحين تؤمن بيئة النمو النفسي المناسب للطفل .
- انشغال الابوين المستمر وابتعادهما عن طفلهما يزرع قي نفسه الالم ويعرضه للعقد والاضطرابات النفسية.
- الابتعاد عن الخلافات العائلية امام الاطفال يبعدهم عن العقد والاضطرابات النفسية.
- الأبوان والمعلمون هم القدوة والمثل الاعلى للأطفال، فهم يقلدونهم في حسناتهم وسيئاتهم والتصرف الصحيح أمام الطفل يعلمه الأخلاق الحميدة ويهذب شخصيته.
- ان تقويم السلوك المخطوء للطفل يعتمد على قدرة الأبوين والمعلمين في مد وتعزيز جسور الثقة المتبادلة.
- ان الاسلوب الأمثل والأسهل لبناء الثقة المتبادلة بين المربي والطفل هو ابداء الحب والاحترام الحقيقي للطفل والإصغاء له لفهم معاناته ومشاكله ومساعدته على حلها.
- ان فترة تربية وتعليم الطفل في المدرسة هي فترة بالغة الاهمية فمن خلالها يمكن اكتشاف ومعالجة اي خطا في تنشئة الطفل وعلى نموه ونضجه النفسي واداءه في مجتمعه مستقبلا.

اهم الاضطرابات النفسية لدى الاطفال

- ❑ **الاضرابات السلوكية: (فرط الحركة وتشتت الانتباه, اضطراب السلوك العدواني)**
- ❑ **الاضطرابات النمائية: (النوعية, والشاملة مثل التوحد والتاخر العقلي)**
- ❑ **الاضطرابات العاطفية: وهي الاضطرابات العاطفية المشابهة للكبار (يتم التطرق لها في الفصل الاخير)**
- ❑ **سوء استخدام المواد: (يتم التطرق لها في الفصل الاخير)**
- ❑ **الصرع**

انواع النمو لدى الاطفال: ان لنمو الطفل جوانب عديدة اهمها:

١) **النمو الجسمي** (نمو الطول, نمو الوزن, الاسنان اللبنية والدائمة, النمو الفسيلوجي والتي تشمل معدل التنفس, دقات القلب, ضغط الدم, عدد الوجبات الغذائية وساعات النوم التي يحتاجها)
٢) **النمو الحركي** (الحاسة العضلية, الفروق الفردية بين الجنسين في الناحية الحركية)
٣) **النمو الحسى** هو نمو الحواس المختلفة للطفل ويبدء من الولادة (البصر. السمع - اللمس - التذوق – الشم).
٤) **النمو العقلي** (اكتساب المعرفة, التفكير المجرد, حب الاستطلاع, تمايز القدرات)
٥) **النمو اللغوي** (تعلم القراءة, تكوين الجمل, القراءة الجهرية والصامتة, التعبير الشفوي والتحريري)
٦) **النمو الانفعالي** (تكوين العواطف ويتضمن البكاء والغضب والحب والكره والخوف والبهجة)
٧) **النمو الاجتماعي** (السمات الذاتية, التعاون, العادات, الولاء للاصدقاء, الفروق بين الجنسين, المكانة الاجتماعية)

فالطفل كائن اجتماعي ينمو منذ اللحظة الاولي في اطار اجتماعي واختلاف التنشئة الاجتماعية يؤدي الي اختلاف السلوك الاجتماعي، وان كل هذه الجوانب تتفاعل مع بعضها لتؤثر في الشكل الكامل والنهائي للبناء النفسي. للفرد الذي يعتمد على الصفات الخلقية للطفل (البنية) وظروف تنشئته (المحيط) والتفاعل بين هذين المحددين.

السمات العامة للنمو بمختلف المراحل العمرية وبما يساعدنا في الأكتشاف المبكر لأي انحراف عن المعتاد.

يمر كل الأطفال عادة أثناء نموهم بأدوار متعاقبة من النمو النفسي. والإجتماعي والمعرفي بموازاة النمو البدني والحركي وتظهر عليهم خلالها سمات وخصائص متشابهة عموماً، ولكن لايوجد عمر معين ثابت لظهور لكل سمة بل هو مدى عمري عام، ويختلف الطفل الواحد عن الآخر في العمر الذي تظهر فيه السمة المعينة. وإذا ظهرت سمة معينة بعمر مبكر (كالتسنين أو الكلام المبكر) فهذا لايعني ان الطفل سيكون عبقرياً بالضرورة كما ان تأخر ذلك لايعني انه متخلف بالضرورة؛ لذا لابد من دراسة مجموعة السمات الموجودة للطفل ومقارنتها بالمتوقعة لمرحلته العمرية قبل إعطاء التقييم النهائي عنه. وفي كل دور تظهر بعض الأعراض والمشاكل النفسية التي تعتبر مقبولة طبياً لتلك المرحلة العمرية. ان معرفتنا لسمات مراحل النمو هذه تساعدنا في التمييز بين ماهو طبيعي وغير طبيعي للمرحلة العمرية فسلس البول اللاإرادي مثلاً يعتبر طبيعياً في عمر الثلاث سنوات ولكنه غير طبيعي بعمر الثمان سنوات.

علامات تطور الطفل الاساسية	العمر الذي يتم فيه معظم الاطفال هذا النشاط	نشتبه وجود خلل ما في نمو الطفل اذا لم يتمكن من اتمام النشاط في هئا العمر
يتجاوب عند سماع الاصوات	١-٣ شهر	بعد الشهر الرابع
يتجاوب عند سماع اسمه	١-٣ شهر	بعد الشهر الرابع
يبتسم للاخرين	١-٤ شهر	بعد الشهر السادس
يبقى راسه مرفوع	٢-٦ شهر	بعد الشهر السادس
يقعد من دون ان يتكئ	٥- ١٠ شهر	بعد الشهر ١٢
يقف من دون ان يتكئ	٩- ١٤ شهر	بعد شهر ١٨
يمشي جيدا	١٠- ٢٠ شهر	بعد ٢٠ شهر
يركب جمل من ٣- ٤ كلمات	١٦- ٢٠ شهر	بعد السنة الثالثة
ياكل ويشرب بمفرده	٢-٣ سنة	بعد السنة الرابعة
يستطيع ان يقول اسمه	٢-٣ سنة	بعد السنة الرابعة
يتدرب على دخول الحمام	٣-٤ سنة	بعد السنة الرابعة
يتجنب المخاطر	٣-٤ سنة	بعد السنة الرابعة

احصائيات عالمية:

- تشكل الاضطرابات النفسية لدى الاطفال (٢-١٧سنة) نسبة ١٠% منهم
- اهمها اضطرابات عاطفية اوسلوكية، أو نمائية
- فرط الحركة ونقص الانتباه هو الأكثر انتشار
- الفتيان أكثر اصابة بفرط الحركة ونقص الانتباه، مشاكل سلوكية، طيف التوحد، والقلق
- الفتيات أكثر اصابة بالاكتئاب
- الانتحار هو السبب الرئيسي الثاني للوفاة للاعمار ١٢-١٧سنة

❑ **الاضطرابات السلوكية (اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه)**

هو الاكثر انتشاراً وقد تصل الى ١٠% من الاطفال ويقل مع تقدم عمر الطفل واهم العلامات التشخيصية له:

- الاغلب ذكر بنسبة ٤/ ١, تبدء الاعراض بالظهور قبل سن ٦ سنوات ولستة اشهر على الاقل.
- الحركة الزائدة: مثلاً لا يقدر أن يجلس على كرسيّ طوال حصّة كاملة, الثرثرة, ومقاطعة الآخرين مما يسبب مشكلات في التعلّم والدراسة.
- صعوبة التركيز وتشتت الأنتباه: لا يستطيع إنجاز ما يبدأ به, الانتقال من نشاط إلى آخر بشكل كبير، سهولة الالتهاء عن الواجب, وقلة النظام والترتيب، لاسيما في المواقف التي تتطلب هدوءاً نسبياً. فقد يقوم الطفل أو المراهق بالركض والقفز، أو النهوض عن مقعده عندما يُفترض به البقاء فيه، أو الثرثرة المفرطة و إحداث ضجة، أو التململ. مما يؤثر على قدرته على التعلم وعيش حياته بشكل طبيعي.
- الاندفاعية واللاأبالية: يفعل أشياء فجأة من دون التفكير فيها مما يسبب تحطيم ألاشياء في المنزل بدون قصد وعدم القدرة على انتظار دوره في لعبة ما أو الإفراط في الحديث أو إحداث ضجة.
- ان الأعراض ملحوظة في مكانين على الأقل (مثلاً في البيت والمدرسة او غيرها)
- مع تقدم العمر تتحسن اغلبية الاطفال ولكن البعض منهم تبقى المشكلة معهم الى مرحلة البلوغ.

❑ **الاضطرابات السلوكية (اضطراب السلوك العدواني)**

قد تكون هناك نوبات غضب حادة ومتكررة بشكل غير عادي، وعصيان شديد ومتواصل. وقد تتسم اضطرابات السلوك بنمط متكرر ومستمر للسلوك اللاجتماعي أو العدواني أو المتحدّي. وهو أخطر من عبث الأطفال أو تمرد المراهقين العادي

السلوكيات العدوانية تقع في أربع فئات

١) العدوان على الناس/ الحيوانات: (مستويات مفرطة من العراك أو التنمر),(القسوة مع الحيوانات), (السلوك الاستفزازي والمتحدّي ونوبات غضب حادة ومتكررة).
٢) تدمير الممتلكات واشعال النيران.
٣) الغش والكذب أو السرقة وتناول الكحول او المخدرات.
٤) انتهاك خطير للقواعد (العصيان, التغيب عن المدرسة, الهروب من المدرسة)

ملاحظة

- نسبة الاضطراب بين الاطفال ٤% والاغلب بين الذكور.
- ينبغي أن تأخذ الأحكام المتعلقة بوجود اضطراب سلوكي عدواني في الاعتبار المستوى النمائي للطفل أو المراهق ومدة المشكلة السلوكية (ما لا يقل عن ٦ أشهر) والتي عادة تشخص في عمر (٦) سنوات.
- حصول المرض في طفل لايتميز بالعدوانية سابقاً, فقد يكون ناتج عن معاناة الطفل من الكآبة أو من أحد الأمراض (العاطفية) العصابية الاخرى.
- من اهم مخاطره هو الجنوح في المراهقة والذي يكون عادة مسبوقاً باضطراب السلوك في الطفولة وبعلاقات عائلية تتسم بالاضطراب والعدوانية وبفقدان أحد أو كلا الأبوين، وقد يكون أحد الأبوين مضطرباً نفسياً.

الاضطرابات النمائية

أ. الاضطرابات المحددة (النوعية)

- اضطراب اللغة والكلام
- اضطراب المهارات الحركية
- اضطراب المهارات المدرسية

ب. الاضطرابات الشاملة:

- اضطراب طيف التوحد
- التاخر (التخلف) العقلي

يتم تحديد الطفل الذي يعاني من تأخر في النماء باستخدام مقايس النماء المحلية أو مقارنة الطفل مع أطفال آخرين من نفس العمر في نفس البلد. (تحديد العمر الذي بدأ فيه الطفل بالابتسام، الجلوس، الوقوف بنفسه، المشي، الكلام، فهم التعليمات، التواصل مع الآخرين.) اما بالنسبة للأطفال الأكبر: نستخدم كل ماذكر مع ملاحظة مدى قدرتهم على القيام بالواجبات المدرسية أو الأنشطة المنزلية اليومية.

ايضا يتطلب البحث عن:

- تاريخ عائلي من الاضطراب النمائي.
- وجود إعاقة بصرية و سمعية.
- صرع مقترن.
- علامات مقترنة من الإعاقة الحركية أو الشلل الدماغي.
- شذوذ في التواصل (على سبيل المثال، عدم ا ستخدام المهارات اللغوية اجتماعياً، أو الافتقار إلى المرونة في استخدام اللغة).
- أنماط سلوك واهتمامات وانشطة ضيقة النطاق ومتكررة.
- فقدان مهارات مكتسبة من قبل.

اضطراب طيف التوحد:

- اكثر بين الذكور من الاناث ٤/ ١وتبلغ نسبة الإصابة به واحد بالف من الاطفال.
- عادة الطفل ينمو جسديا بشكل طبيعي وقد يرافقه بنوبات الصرع أو بحالات التخلف العقلي.
- يشخص هذا المرض بعمر ثلاث سنوات ويتميز بثلاث صفات:

١) **صعوبات في التواصل الاجتماعي والتفاعل العاطفي:** ومن علاماته تجنب النظر في عيون الآخرين، وعدم إظهار الفرح أو السعادة عند ملاطفته أو حمله ومداعبته والمرح مع الآخرين.

٢) **صعوبات في التواصل اللغوي:** حيث لا يمتلك أية قدرة على الكلام أو أنه يتكلم بشكل غير طبيعي مثل تكرار ما يقال أمامه بشكل ببغائي أو استعمال الضمائر بشكل معكوس.

٣) **يؤدي حركات غير طبيعية:** حيث تكون حركاتهم خرقاء وغير هادفة ومكررة.

- يتعاملون مع الأشخاص وكأنهم أشياء (يمسك بيد أمه ليحرك بها كرته وكأن يد أمه عصا),
- يهتمون بأجزاء صغيرة من ألعابهم ويحطمون باقي أجزاء اللعبة
- يقومون بحركة ثابتة لفترة طويلة (إغلاق وفتح الباب لمدة طويلة بدون ملل)
- الإصرار على طقوس معينة مثل الكيفية التي يقدم بها طعامه أو الإصرار على وجود أشياء معينة وعند تغيير أي من هذه الطقوس يغضب ويحتج بعنف

التاخر (التخلف) العقلي:

- التأخر العقلي: يعني أنّ الوظائف العقلية لم تنموا او لم تتطور بالشكل السليم كما هو متوقّع بالنسبة إلى عمر الطفل.
- يواجه الأطفال الذين يعانون تأخراً عقلياً صعوبةً في تعلّم المهارات الجديدة.
- تؤثر الإعاقة على كافة نواحي التطور عند الطفل, من تعلّم الجلوس والمشي إلى تعلّم الكلام والأكل.
- التأخر العقلي ليس مرضاً, بل موجودة (منذ الولادة عادةً) ويستمرّ طوال حياته.
- ليس ثمة علاج للتأخر العقليّ,
- قد يكون التأخر العقليّ بسيطا وهو (الشائع) أو متوسّطاً أو شديد.
- غالباً ما تُكتشف الحالات المتوسطة والشديدة من حالات التأخر العقلي قبل عمر السنتين.
- ويُلاحَظ التأخر العقلي البسيط عادة للمرة الأولى عند شخص مراهق أو بالغ, و لم يُكتشف في سن الطفولة, ولم تظهرالمشكلة إلا عندما واجه الشخص مسؤوليات وضغوطات جديدة في الحياة.
- لمعرفة مستوى النمو العقلي يستخدم معامل الذكاء (IQ) الذي يقاس حسب العمر. يعتبر الذكاء طبيعياً إذا كان ٩٠ - ١٢٠ درجة أما الفئة الواقعة بين ٧٠ إلى ٩٠ فهي فئة بطيئي التعلم ومعامل الذكاء للمصابين بالتاخر العقلي فيكون ما دون ٧٠ درجة.

- **ينبغي أن نشتبه باحتمال وجود تأخر عقليّ عند الطفل أو الطفلة في الحالات الآتية:**
  - إذا تأخّر في القيام بالنشاطات الدالة على علامات التطور الأساسية
  - إذا واجه صعوبات مدرسية وصعوبة في اللعب مع الأطفال الآخرين
  - إذا كان يعجز عن تنفيذ التعليمات التي تعطى له.
- **ينبغي أن نشتبه باحتمال وجود تأخر عقليّ عند المراهق في الحالات الآتية:**
  - إذا واجه صعوبات في العلاقات الاجتماعية مع المراهقين الآخرين
  - إذا لم يكن قادراً على التعلّم بالسرعة التي يتعلّم بها الطلاب الآخرون في الصف نفسه.
  - إذا صدر عنه سلوك جنسي غير لائق.
- **ينبغي أن نشتبه باحتمال وجود تأخر عقليّ عند الشخص البالغ في الحالات الأتية:**
  - إذا واجه صعوبات في إتمام النشاطات اليومية.
  - إذا واجه مشكلات في التكيّف الاجتماعي (مثل اكتساب الأصدقاء).

اسباب الناخر العقلي:

- **المشكلات الجينيّة:** مثل متلازمة داون
- **الحمل المتأخّر:** أي الحمل الذي يحصل في عمر متأخر للأم, حيث تزداد نسبة الخطورة بالإصابة بمثل هذه الاضطرابات مع تقدم عمر الأم.
- **المشكلات السابقة لولادة الطفل:** سوء التغذية عند الأم وإفراطها, الكحول, لألتهابات التي تنتقل من الأم إلى الجنين أثناء الحمل مثل الحصبة الألمانية والزهري و التوكسوبلازموسز، نقص اليود يولد الطفل مع قصور في وظيفة الغدة الدرقية).
- **المشكلات في أثناء الولادة:** مثل المخاض الطويل, أو التفاف الحبل السرّي حول عنق الطفل
- **المشكلات في السنة الأولى بعد الولادة:** مثل التهابات الدماغ, واليرقان الحاد والمطوَّل, والتشنّجات الخارجة عن السيطرة, والحوادث, وسوء التغذية الحاد, والتسمم بالرصاص
- **المشكلات في العناية بالطفل:** مثل قلة التشجيع, وسوء المعاملة, والإهمال العاطفيّ

الصرع:

هو نوبات سقوط مفاجئة لاارادية متكررة ناتجة عن إضطراب في وظائف الدماغ ويرافقها إضطراب كلي أو جزئي في الوعي والسلوك وتنتهي تلقائياً ويقدر بأن واحداً من كل (١٣) شخص معرض له.

الأسباب:

أولاً- ذاتي (أولي): مجهول السبب.

ثانياً- ثانوي حيث يحدث الصرع جراء وجود أمراض أخرى مثل:

أ- أمراض الدماغ الموضعية (كالأورام) أو الشاملة والإلتهابات والشدة على الرأس.

ب- حالات التسمم ونقص الأوكسجين وهبوط السكر والكالسيوم والأملاح الأخرى وعجز الكبد والكليتين والقلب والحمى العالية، ... إلخ.

ت- الأعراض الأنسحابية للكحول والعقاقير أو التسمم بها

تشخيص الصرع

- الوصف السريري التفصيلي للنوبة من قبل المريض أو مرافقيه
- التخطيط الكهربائي للدماغ
- التصوير الشعاعي للجمجمة، مفراس الدماغ و الفحوص المختبرية للدم
- يعتمد التشخيص النهائي على تقدير الطبيب المستند للفحص السريري .
- كما أن كل حالة صرع تبدأ بعد سن العشرين تعتبر ثانوية ويجب إجراء التحريات كلها بحثاً عن السبب العضوي الأساس وعلاجه.
- أما الحالات قبل هذه السن فمعظمها أولية وبدون سبب معروف وقد نكتفي بتحريات قليلة لها.

- نوبة الصرع عادة تنتهي تلقائياً ولاتستوجب أية مداخلة عدا المحافظة على تنفس المريض بثني الرقبة للخلف قليلاً وللجانب مع فتح الأربطة والأزرار عن الصدر والعنق مع التأكد من عدم وجود شيء في الفم تجنباً للإختناق ويفضل وضع عازل في الفم.
- على المريض إستخدام علاج الصرع لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات بعد آخر نوبة ثم يقلله تدريجياً وببطء وعلى مدى عدة أشهر.

الاعتداء الجنسي على الاطفال

مقدمة:

- ظاهرة ذات أبعاد خطيرة تهدد حياة الاطفال بصورة خاصة والمجتمع عامة.
- أن ١/ ٤ من ألاطفال (ذكور واناث) يكون ضحية للإعتداء الجنسي.
- هو خرق فاضح لحقوق الطفل وغالبا ما يبقي فى ذهن الطفل طوال حياته.
- تتم من قبل شخص يعرفونه ويثقون فيه سواء كان قريباً او صديقاً للعائلة او وصياً.
- يتم عندما يحاول فتى او شخص بالغ استغلال طفل للحصول على المتعة الجنسية.
- يبدأ الاعتداء فى العادة تدريجيا ويزيد مع مرور الوقت.
- من النادر استخدام القوة البدنية لإشراك الطفل فى نشاط جنسي.
- الاطفال بطبعهم ميالون للثقة ويعتقدون بأن الكبار دائماً على حق.
- الغالبية العظمى من حالات الاعتداء الجنسي بالأطفال يتم التكتم عليها.
- يساهم الصمت فى استمرار وانتشار الاعتداء الجنسي ويحمى المعتدين.
- المعرض للتحرش اوالاغتصاب قد يتولد لديه نوعا من الشذوذ الجنسي مستقبلا.
- على الآباء والامهات والتربويين مواجهة آمكانية تعرض أطفالهم للإساءة الجنسية.

يتم الاعتداء الجنسي للاطفال من خلال:

- خداعهم
- او رشوتهم
- او الضغط عليهم
- او تهديدهم
- إو اجبارهم
- وعادة لا يبلغ الاطفال عن الاعتداء او الاستغلال الجنسي.

انواع الاعتداءات الجنسية

قد تكون الاعتداءات الجنسية (بدنية او شفوية او مشتركة بينهم) واهم انواعها:

- الكلام البذىء والتحرش الجنسي.
- الملامسه أو المداعبة الجنسية.
- تحريض الطفل على لمس جسد المعتدي.
- مشاهدة الاطفال النشاطات الجنسية للكبار.
- عرض الاعضاء التناسلية على طفل بغية تأمين رضا جنسي ذاتي.
- تعريض الطفل لمواد إباحية عبر الإنترنت كالأفلام والصور الخليعة
- جعل الاطفال يظهرون عراة فى الواقع أو بشكل جنسي فى الأفلام.
- الاكراه الجنسي اي الاغتصاب أو محاولة الاغتصاب .
- البغاء والاتجار بالجنس وغيرها.
- زواج الاطفال.

أماكن وقوع حوادث الاعتداء الجنسي

- ❑ **الاماكن الخاصة: منزل العائلة / الاقارب / الاصدقاء / السيارة.**
- ❑ **الاماكن العامة:**
  - المدارس/ الاندية/ الاماكن المهجورة.
  - مؤسسات الايواء للايتام والمعاقين والاحداث.
  - الحدائق العامة.
  - الاسواق/ المطاعم.
  - دور السينما.
  - المراكز الرياضية.

جنس الضحية

- نسبة الذكور المعتدي عليهم أكثر من الاناث (٦٥% ذكور ,٣٥ % إناث)
- ٧٥% من المعتدين على الاطفال جنسياً هم من الكبار (البالغين) و٢٥ % من المراهقين.
- ٧٥% من المعتدين هم اشخاص يفترض ان يكونوا موضع ثقة الطفل.
- ٩٥% من المعتدين على الاطفال هم من الذكور .

عمر الضحية

- تحدث الاعتداءات مابين سن ٤ الى ١٦ سنه
- اعلى نسبة حوادث الاساءة الجنسية تحدث بين ٧ -١١ سنه. (مرحلة الابتدائية)

هوية القائمين بالاعتداء الجنسي

- ❑ **قد يكون من الاقرباء: الاكثر شيوعا**
  - الاب, الاخ.
  - الخال, العم.
  - أزواج الأمهات .
  - الاقارب, اصدقاء العائلة
- ❑ **قد يكون من الغرباء:**
  - الخادم, السائق, البائع.
  - القائمين على نشاطات الطفل (المربين).
  - التربويين, المدربين.
  - الاحداث فى المدارس ودور الرعاية وغيرها من المؤسسات.

علامات الاعتداء الجنسي

١. التغيير السلوكي للاطفال وهو المهم: على الاهل والتربويين الانتباه للتغيرات السلوكية ومثال ذلك:

- تراجع مستوى الأداء الدراسي والاجتماعي
- الكذب
- مشاكل الانضباط
- الهروب (التشرد)
- إيذاء الذات
- قلة احترام وتقدير الذات
- تقليد السلوك الجنسي للكبار
- اللعب الجنسي المستمر مع الاطفال او اللعب مع الحيوانات الاليفة

- ظهور معرفة جنسية من خلال السلوك واللغة تعتبر شاذة بالنسبة لأعمارهم
- التلميح او التعليق غير المباشر او العبارات العابرة عن الاعتداء
- خوف وكراهية بعض الاشخاص او الاماكن
- القلق والخوف المستمر
- الكوابيس والرعب الليلي
- اضطراب فى الاكل والنوم
- الانعزالية والاكتئاب
- الانطواء عن العائلة والاصدقاء والانشطة الاعتيادية
- النكوص لسلوك طفولى اقل من عمره مثل: مص الاصابع وسلس البول
- الاستحمام الزائد او اهمال النظافة
- تعاطى مخدرات او تدخين والكحول
- السلوك السيء او العدوانية

ملاحظة هامة

ليس كل طفل لديه الاعراض السلوكية السابقة يعني معتدى عليه جنسياً لكن يجب وضع احتمالية الاعتداء الجنسي كأحد اسباب السلوك.

٢. الادلة البدنية: ان الادلة البدنية للاعتداء الجنسي من النادر ملاحظتها من قبل الاهل او التربويين، ويتم تشخيصها من قبل الطبيب بعد فحص الطفل مثال ذلك:

- التهاب الفرج/ المهبل.
- امراض تناسلية (قد يتأخر اكتشافها لسنوات)
- خدوش فى الاعضاء التناسلية الخارجية (الفرج او الشرج)
- وجود جسم غريب او عبث بدنى باليد فى الفرج
- الورم والنزيف او حكة فى الفم او الاعضاء التناسلية
- التهاب البول او الامراض المعدية جنسيا
- الالام مجهولة السبب
- صعوبة المشي او الجلوس
- ملابس دخلية ممزقة او ملوثة بالدم .
- الحمل فى سن صغيرة.

اساليب وقائية عامة

- توعية الأطفال بفسيولوجيا الجسم وتعريفهم بوظائف الجسم باسلوب مبسط.
- الرد على استفسارات الأطفال الجنسية والحساسة وعدم التهرب منها.
- واجب توعية الأطفال جنسيا باسلوب ينسجم مع العمر وطبيعة الطفل.
- تعريف الأطفال بالفرق بين اللمسات البريئة وغير البريئة وضرورة حماية أنفسهم.
- تشجيع أي مصارحة من قبل الأطفال للأهل وتجنب ردة الفعل العنيفة من الأهل والعقاب أو التوعد والذي قد يدفع الأطفال لكتمان الأمور عن الأهل مستقبلا.
- الطفل المدرك لمظاهر الجنس التي قد تمارس معه والنتائج المترتبة عليه هو الأقدر على حماية نفسه.
- تقوية شخصية الأطفال وزرع الثقة بالنفس تجعل من الصعب الاعتداء عليه.
- توعية الأبناء بعدم الاقتراب من الغرباء أو تصديقهم مهما قالوا لهم أشياء حقيقية.
- عدم الثقة بالأقارب والمحارم لدرجة كبيرة بل يجب التعامل معهم بحذر وعدم تأمينهم على الأطفال والمحارم مثل (الأخ والخال والعم وحتى الأب).

- تحذير الأبناء وتنبيههم لعدم السماح لأي كان أن يقبلهم على فمهم أو رقبتهم أو حتى إمساكهم في مناطق حساسة ويجب إخبار الطفل أن مثل هذا التصرف هو تحرش ويجب أن يبتعد الطفل بسرعة ويخبر الأهل.
- المراقبة التامة للأبناء وعدم إهمالهم مثل (ارسال الطفل إلى زيارة الآخرين وحده, ارسال الطفل للشراء من المحلات دون مراقبة).
- إخبار الأطفال عن حوادث حصلت مع أطفال آخرين وبيان الأسباب والنتائج.
- تعليم الاطفال أن أجسامهم هى ملكهم وليس من حق احد أن يلمسها.
- تعليم الاطفال مهارة الرفض(لا) لأي طلب يحسون فيه بعدم الارتياح من اقرب الاقربين أو اصدقاء العائلة.
- تعليم الاطفال في الإبلاغ عن اى شخص بالغ يطلب منهم كتمان سر من الاسرار.
- ان قواعد الحماية والسلامة تسري على جميع البالغين وليس على الغرباء فقط.
- من أكثر الأشياء خطورة وصول متحرش إلى منزلك، ولتجنب ذلك ينبغي:
  - عدم السماح بدخول أشخاص غرباء للمنزل.
  - عدم فتح الباب لأشخاص دون التأكد من هويتهم.
  - عدم ترك الأطفال بمفردهم في المنزل لفترات طويلة.
  - في حال وجود مساعدين أو مربيات يجب التأكد من عدم وجود أي سوابق جنائية لهم.
  - عدم ترك الأطفال دون ملاحظة لفترات طويلة.
  - عدم السماح بدخول أفراد التصليحات والصيانة إلا في وجود أكثر من شخص بالغ قادرعلى التصرف والمقاومة حال أي طارئ.

الرعاية الصحية النفسية المدرسية

المدرسة هي المؤسسة الرسمية التي تقوم بعملية التربية ونقل الثقافة المتطورة وتوفير الظروف المناسبة للنمو جسميا وعقليا وإنفعاليا وإجتماعيا. وعندما يبدأ الطفل تعليمه في المدرسة يكون قد قطع شوطا لابأس به في التنشئة الإجتماعية في الأسرة فهو يدخل المدرسة مزودا بالكثير من المعلومات والمعايير الإجتماعية والقيم والإتجاهات. والمدرسة توسع دائرة هذه المعلومات والمعايير والقيم والإتجاهات في شكل منظم وفي المدرسة يتفاعل التلميذ مع مدرسه وزملائه ويتأثر بالمنهج الدراسي بمعناه الواسع علما وثقافة وتنمو شخصيته من كافة جوانبها. وتستخدم المدرسة أساليب نفسية عديدة أثناء تربية التلاميذ منها دعم القيم الإجتماعية عن طريق المناهج, وتوجيه النشاط المدرسي بحيث يؤدي إلى تعليم الإساليب السلوكية المرغوبة وإلى تعليم المعايير والأدوار الإجتماعية والقيم, والثواب والعقاب, وممارسة السلطة المدرسية في عملية التعليم والعمل على فطام الطفل إنفعاليا عن الأسرة بالتدريج, وتقديم نماذج صالحة للسلوك السوي إما في شكل نماذج تدرس لهم أو نماذج يقدمها المدرسون في سلوكهم اليومي مع التلميذ. وتؤثر العلاقات الإجتماعية في الأسرة على الصحة النفسية للتلميذ والتوافق المدرسي على النحو التالي:

- العلاقات بين المدرس والتلميذ التي تقوم على أساس من الديمقراطية والتوجيه والإرشاد السليم تؤدي إلى حسن العلاقة بين المدرس والتلميذ وإلى النمو التربوي والنفسي السليم.
- العلاقات بين التلاميذ بعضهم البعض التي تقوم على أساس من التعاون والفهم المتبادل تؤدي إلى الصحة النفسية.
- العلاقات بين المدرسة والأسرة والتي تكون دائمة الإتصال (وخاصة عن طريق مجالس والآباء والمعلمين) تلعب دورا هاما في إحداث عملية التكامل بين الأسرة والمدرسة في عملية رعاية النمو النفسي للتلاميذ.
- إن التحصيل العلمي وإكساب المعارف والمعلومات ليس ولا ينبغي أن يكون بؤرة تركيز المدرسة, ولكن يجب أن يضاف إلى ذلك الإهتمام بتوافق التلميذ شخصيا وإجتماعيا وبصحته النفسية والجسمية وبتكوين عادات سلوكية وإتجاهات موجبة نحو المدرسة ونحو العمل ونحو الأشخاص بصفة عامة حتى يشب إنسانا صالحا.
- وفي وضع المناهج يجب عمل حساب الصحة النفسية للتلاميذ والمربين أيضا, فيجب أن تكون المناهج مناسبة تراعي حاجات التلاميذ وقدراتهم. ويجب أن يكون المنهج مرتبطا بمواقف الحياة الطبيعية والعمل على إحداث

التوافق مع مواقف الحياة. كذلك يجب الإهتمام بملائمة المناخ الإجتماعي في المدرسة داخل وخارج الفصل وفي النشاط خارج المنهج.

أما عن دور المدرس في العملية التربوية فنلاحظ عليه ما يلي:

- يلعب المدرس دورا هاما في عملية التربية وفي رعاية النمو النفسي وتحقيق الصحة النفسية للتلميذ, فهو دائم التأثير في التلميذ منذ دخوله المدرسة حتى تخرجه, وهو نموذج سلوكي حي يتحذيه الطفل ويتقمص شخصيته ويقلد سلوكه, وهو ملقن علم ومعرفة ينمي معارف التلاميذ, وهو موجه سلوك التلميذ إلى ألافضل عن طريق وضعه في خبرات سلوكية سوية.
- المدرس ليس ناقل معلومات ومعارف فقط ولكنه بالإضافة إلى ذلك معلم مهارات التوافق ومشخص مظاهر وأعراض أي إضطراب سلوكي, ومصحح ومعالج لهذا الإضطراب.
- يجب أن يتمتع المربون (المعلمون والوالدان) أنفسهم بالصحة النفسية, ففاقد الشيء لايعطيه, ويتطلب ذلك تحقيق الأمن النفسي. والإستقرار النفسي. والتوافق مع التلاميذ والديمقراطية في التعامل معهم, وأن تكون النظرة إلى الحياة إيجابية ومتزنة.
- مشكلات المدرسين ومظاهر سوء توافقهم الشخصي. والإجتماعي يجب العمل على حلها, ومن هذه المشكلات مايتعلق بالناحية الإقتصادية والوضع والمكانة الإجتماعية والتعب والإرهاق...الخ.
- تتأثر الصحة النفسية للتلاميذ بشخصية المربي الذي يجب أن يكون قدوة صالحة للتلاميذ في سلوكه.
- كلما كانت العلاقة سوية بين المربين والأولاد وبين الأولاد بعضهم بعض وبين المدرسة والأسرة كلما ساعد ذلك على حسن توافقهم النفسي وشعورهم بالأمن مما يؤدي إلى النجاح والتوفيق ولذلك يجب العمل على تكوين إتجاهات موجبة لدى المربين وذلك عن طريق التوجيه والإرشاد للمربين ومجالس الآباء والمعلمين.
- على المدرس أن يعمل كمرب يعلم ويوجه ويعالج في بعض الأحيان وإنه يعلم العلم ويوجه النمو ويعالج ما يستطيع علاجه من مشكلات تلاميذه ويحيل ما لا يستطيع علاجه إلى الأخصائيين في العيادات النفسية.

في ضوء ما سبق نجد أن التربية تشترك في كثير من أهدافها مع الصحة النفسية.

الهدف من الرعاية الصحية النفسية المدرسية

- ✓ تقديم خدمات صحية نفسية جيدة تساعد في تامين البيئة المناسبة للنمو النفسي. والاجتماعي السليم لابنائنا لضمان مجتمع أمن في المستقبل.
- ✓ تؤمن الاكتشاف المبكر للاضطرابات النفسية ومعالجتها.

الجهات المسؤولة عن تقديم الرعاية الصحية النفسية المدرسية

تقدم الرعاية الصحية النفسية المدرسية بالتعاون والتكامل بين:

١) وزارة الصحة المتمثلة بكل من (وحدة الصحة النفس-اجتماعية ووحدة الصحة المدرسية في المراكز الصحية ومكتب الخدمات المدرسية النفسية والاجتماعية لدائرة الصحة ضمن الرقعة الجغرافية للمدارس).

٢) وزارة التربية المتمثلة بالمدرسة والكوادر التربوية من (مدراء ومرشدين تربويين أومن يقوم مقامهم وبقية الملاكات التربوية في المدرسة).

٣) اسرة الطالب.

دور المدرسة في الرعاية النفسية

١- المساعدة في اكتمال نمو الشخصية السليم. (التنشئة السليمة)

٢- التاكد من توفر البيئة المناسبة للتربية والنمو النفسي السليم.

٣- زيادة المعارف وتطوير المهارات النفسية والاجتماعية وتشجيع السلوك الايجابي للطالب.

٤- مساعدة الطالب على التعرف على خصائص نفسه وفهم قدراته وميوله واختيار التخصص المناسب له.

٥- مساعدة الطلبة الذين يعانون من مشكلات نفسية واجتماعية حتى يتحقق لهم التوافق مع انفسهم ومع الاخرين.

٦- العمل على اكتشاف الموهبين ورعايتهم وتوفير الامكانات والفرص المتاحة لتنمية مواهبهم.
٧- الاهتمام بحالات التأخر المدرسي والعمل على دراسة الاسباب ومعالجتها.
٨- الاهتمام ورعاية الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة.

طرق الإرشاد التربوي

١-الطرق الاقتدائية: اتباع القدوة الحسنة للطالب.
٢-الطرق الوعظية: التي تعتمد أسلوب النصح والموعظة والترغيب والترهيب.
٣-الطرق العقلية الانفعالية: وتعتمد على مخاطبة العقل ومشاعر الفرد.
٤-الطريقة القصصية: تتم بسرد القصص المؤثرة والتي نستدل منها على السلوك المرغوب وتعززه والسلوك غير المرغوب لتجنبه.

ماهي خدمات الرعاية الصحية النفسية المدرسية التي تقدم في وحدات الصحة النفس-اجتماعية للمراكز الصحية

١. يتواجد مسؤول الوحدة النفس –اجتماعية في كل مركز صحي ضمن لجنة فحص الطلبة الجدد للتاكد من سلامة حالتهم النفسية والعصبية وسلامتهم الجسدية للنمو النفسي السليم.(حجم الجسم والرأس, تناسق حركات الراس والاطراف, البصر, السمع, الكلام, التواصل بالنظر, الاستجابات وتعابير الوجه, سلوك وحركة الطفل)..
٢. فحص التلاميذ والطلبة المحالين من ادارات المدارس بسبب المشاكل النفسية او السلوكية والعمل على تدبيرها.
٣. احالة التلاميذ والطلبة المشكلين الى مكتب الخدمات المدرسية النفسية والاجتماعية (عند الحاجة) لغرض الفحص والتشخيص والعلاج.
٤. متابعة المدارس والتاكد من توفر الظروف المناسبة للتربية والنمو النفسي السليم للتلاميذ والطلبة.
   - ✓ بيئة مناسبة صحيا.
   - ✓ وجود انشطة لاصفية (الرياضة والفنية والادبية والمهارية والاجتماعية).
   - ✓ القدوة والسلوك الحسن للملاكات التربوية.
   - ✓ عدم اتباع اسليب العنف والعقوبات المهينة والاستهزاء والتمييز.
   - ✓ مكافحة التدخين في المؤسسات التربوية.
   - ✓ وجود علاقة تواصل ودية بين الهيئات التعليمية والطلبة واولياء الامور.
   - ✓ تفعيل دور المرشد التربوي لحل مشاكل التلاميذ والطلبة بالتعاون مع ذويهم والادارة واحالة من يحتاج الى المركز الصحي لغرض التشخيص والمعالجة.
٥. التعاون مع مسؤول الصحة المدرسية في المراكز الصحية للقيام بفعاليات التوعية والتدريب للهيئات التعليميه ولذوي التلاميذ والطلبة وبمعدل ندوة شهريا.

مكتب الخدمات المدرسية النفسية والاجتماعية

شرع المكتب حسب قانون رعاية الاحداث رقم (٧٦) لعام ١٩٨٣
الهدف: وقاية الاطفال من الانحراف والجنوح

المادة ١٧:

اولا: تقوم وزارة الصحة بانشاء مكتب الخدمات المدرسية النفسية والاجتماعية في مركز كل محافظة ضمن تشكيلات الصحة المدرسية, يعنى بدراسة ومعالجة الاحدلث المشكلين أو المعرضين للجنوح اللذين يحالون اليه من ادارات المدارس او اية جهة اخرى.

ثانيا: يتالف بقرار من وزير الصحة من:

- طبيب نفسية مختص أو ممارس نفسي أو طبيب اطفال عند الاقتضاء.
- اختصاص بالتحليل النفسي أو علم النفس.
- عدد من الباحثين الاجتماعيين.

➢ **المادة ١٨:**

اولا: يتولى المكتب اجراء الفحص الطبي والنفسي والبحث الاجتماعي للحدث ووفق مايلي:

- فحص الحدث بدنيا وعقليا ونفسيا لتشخيص الامراض التي يشكو منها.
- دراسة حالة الحدث الاجتماعية والبيئة التي يعيش فيها وبيان مدى علاقتها بمشكلته.

ثانيا: ينظم المكتب تقريرا مفصلا عن حالة الحدث البدنية والعقلية والنفسية والاجتماعية واسباب تعرضه للجنوح والمقترحات التي يوصي بها ادارة المدرسة او اي جهة اخرى لمعالجته ولرعايته.

➢ **المادة ١٩:**

اولا : للمكتب الحق ان يستدعي ولي الحدث ويطلعه على التقرير الذي اعده ويطلب تعاونه في تفهم مشكلة الحدث ومساعدته في حلها.

ثانيا: اذا لم يظهر الولي تعاونا مع المكتب أو اعرض عن تفهم مشكلة الحدث أو امعن في اهماله لواجباته, فالمكتب له الحق في ان يطلب من قاضي تحقيق الاحداث أو الادعاء العام اتخاذ الاجراء المناسب بحق الولي ووفق احكام القانون.

➢ **المادة ٢٠:**

اولا: اذا وجد المكتب ان حالة الحدث تستدعي المتابعة فله ان يستعين بقسم مراقبة السلوك.

ثانيا: يتولى مراقب السلوك متابعة حالة الحدث لمدة لاتزيد على ستة اشهر يرفع خلالها تقارير شهرية الى المكتب تتضمن مايطرأ على سلوكه من تغيير.

➢ **المادة ٢١:**

اولا: يعين في كل مدرسة باحث اجتماعي يكون مسؤولا عن حل مشاكلهم , ويقوم احد اعضاء الهيئة التدريسية بذلك عند الاقتضاء .

ثانيا: اذا تعذر على المسؤول في المدرسة حل مشكلة الحدث فعليه عرضه على مكتب الخدمات المدرسية النفسية والاجتماعية.

التعليمات التنفيذية لمكتب الخدمات المدرسية النفسية والاجتماعية

١. يؤلف المكتب في كل دائرة صحة في المحافظات من كل من:

- طبيب اختصاصي بالطب النفسي أو ممارس نفسية إن لم يتوفراختصاصي في دائرة الصحة.
- مدير وحدة الصحة المدرسية في الدائرة
- مدير وحدة الصحة النفسية في الدائرة.
- باحث نفسي أو اجتماعي

٢. يجتمع المكتب مرة واحدة في الأسبوع على الأقل لاستقبال الأطفال المحالين له. ويمكن زيادة عدد ايام الاجتماع بحسب الحاجة.

٣. يكون مكان المكتب في أحد المراكز الصحية التي يمكن الوصول لها بسهولة من مراكز المحافظة الأخرى. ولا يكون المكتب في مستشفى نفسي ولا في وحدة الأمراض النفسية او الطب النفسي في المستشفى العام.

٤. يتم اخبار المراكز الصحية كافة بمكان وموعد دوام المكتب؛ وذلك ليتسنى للمراكز الصحية إحالة الأطفال المُشكلين له بسهولة وبيسر.

الأعراض الشائعة بين التلاميذ والطلبة والتي تستوجب دراسة حالة الطالب النفسية والاجتماعية

- تراجع مستوى الأداء الدراسي أو الاجتماعي للطالب او التلميذ.
- تغير ملحوظ في شخصيته او سلوكه اذا استمر اسبوعين او اكثر أو اهتمامات غير مسبوقة ومعقولة على شخصية الطالب المعروفة.
- المشاكسة المتكررة، الاعتداء، الحركة الزائدة، مخالفة النظام المدرسي،الغياب، الهروب من المدرسة، الانحراف الجنسي.
- حالات التلعثم والتلكؤ في النطق، الخجل والتردد الشديدين، الخوف والفزع، الاعراض الاكتئابية كالبكاء غير المبرر، نوبات السقوط المتكرر عند الازمات، سلس البول، قضم الاظافر، مص الاصابع، اضطراب النوم.

- الأعراض السايكوسوماتية (النفس/ جسدية) مثل التقيؤ، الإسهال، رفض او شراهة الاكل، التعرق، حركات لاإرادية في الوجه أو الأجفان او الرأس او الأطراف.

الية العمل والاحالة

- يتم الاكتشاف المبكر لأي من الاعراض المذكورة سابقا من قبل (عائلة الطالب, المدراء والملاكات التربوية في المدرسة), واللذي يساعد بدوره في نجاح علاج الطالب ويؤمن نمواً نفسياً واجتماعياً سليم له.
- يحالون الطلبة الذين يعانون من مشكلات نفسية واجتماعية الى المرشدين تربويين أومن يقوم مقامهم من اجل تتم مساعدتهم من قبل المرشد التربوي وادارة المدرسة والعائلة حتى يتحقق لهم التوافق مع انفسهم ومع الاخرين.
- تتم احالة الطلبة المشكلين اللذين لايمكن تدبيرحالاتهم في المدرسة الى وحدة الصحة المدرسية بكتاب احالة من ثلاث نسخ توضح فيه اهم الاعراض النفسية والاجتماعية التي يعاني منها الطالب والتي بدورها ستحيل الطالب لوحدة الصحة النفس اجتماعية لتقييم المشاكل النفسية او السلوكية للطالب والعمل على تدبيرها.
- الخدمات المقدمة في وحدة الصحة النفس-اجتماعية هي (التوعية والتثقيف وتقديم النصح, التواصل الجيد وتقديم المشاورة والدعم النفسي, والعلاج الدوائي).
- احالة التلاميذ والطلبة المشكلين من وحدات الصحة النفس -اجتماعية الى مكتب الخدمات المدرسية النفسية والاجتماعية (عند الحاجة) لغرض الفحص والتشخيص والعلاج كاي حالة مرضية تحتاج الى احالة وحسب نظام الاحالة المتبع في المراكز الصحية.



الفصل الثالث

الصحة النفسية للمرأة

تتميز المرأة بمواصفات فسلجية ونفسية خاصة تؤهلها لكي تكون:

- **زوجة** تؤدي دورها في رعاية العائلة والاطفال وما تتخلل حياتها من فترات **الحمل والولادة** ثم **أم** تعمل على حضانة الطفل ورعايته الى ان يكبر.
- حصول اضطراب نفسي او ذهني يتعلق بوظيفتها هذه سيؤدي الى اختلال في **دورها الانثوي** وقد تصاحبه او تعقبه سلبيات تؤثرعلى إفراد العائلة جميعهم

تعاني المرأة انواع مختلفة من الضغوط كما في الشكل ادناه:



لماذا تعتبر الصحة النفسية للامهات مهمة:

- عالميا تعتبر مشاكل صحة الأمهات النفسية تحديا كبيرا على الصحة العامة.
- وفيات الأمهات هي في قلب مؤشرات صحة الأم لما بعد عام ٢٠١٥ لتحقيق ألاهداف التنموية.
- عالميا حوالي ١٠٪ من النساء الحوامل و ١٣٪ من النساء اللواتي أنجبن للتو يعانون من الاضطرابات النفسية.
- النسبة أعلى في البلدان النامية حيث ان ١٦٪ خلال فترة الحمل و ٢٠٪ بعد ولادة الطفل.
- أن حوالي ٢٠٪ من الأمهات في البلدان النامية تعاني من الاكتئاب بعد الولادة والنسبة أعلى بكثير في البلدان ذات الدخل المرتفع.
- الأمهات المصابات باضطرابات نفسية تكون لديها معاناة هائلة وعجز وانخفاض في الاستجابة لحاجة الطفل مما قد يؤثر سلبا على نمو الطفل السليم (يعوق التعلق بين الأم والرضيع، الرضاعة الطبيعية, ورعاية الرضيع).

- تشير الدلائل إلى أن علاج الاكتئاب عند الأمهات يؤدي إلى تحسين نمو وتطور الأطفال حديثي الولادة، ويقلل من احتمالات الإسهال وسوء التغذية بينهم.
- الانتحار هو أحد أهم أسباب الوفاة بين النساء الحوامل وبعد الولادة ثم الذهان الذي هو اقل شيوعا وفي كلاهما ممكن ان يحدث ايذاء الى الاطفال حديثي الولادة.
- الانتحار خلال فترة الحمل وفترة ما بعد الولادة غالبا ما لا تحصى. في إحصاءات وفيات الأمهات وأن كانت تشكل ٢٠-٣٣٪ من وفيات الأمهات.
- اضطرابات الصحة النفسية تؤثر على التزام المراة بالتقيد بخطط رعاية الحمل والرعاية ما حول الولادة للمرأة، مثل مكملات اليود اليومية، وبالتالي لديها القدرة على التأثير سلبا على صحتها وصحة جنينها.
- العلاقة بين الحالة الصحية النفسية للمرأة وصحة وليدها تمتد إلى مرحلة الطفولة المبكرة وخارجها فهي أكثر عرضة من ذوي الصحة النفسية الجيدة في فترة الحمل لولادة طفل قليل الوزن والى ولادة مبكرة وبالتالي يواجهون ضعف بالنمو المعرفي والحركي للطفل، التقزم والمشاكل السلوكية والعاطفية.
- تم ادماج خدمات الصحة النفسية ضمن خدمات صحة الأم والطفل في بعض البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل وكانت التدخلات منخفضة التكلفة مع إشراك مقدمي الخدمات الصحية غير المتخصصة وناجحة واثمرت ليس فقط على الأمهات ولكن أيضا على نمو وتطور الأطفال.

عوامل الخطورة للاضطرابات النفسية للامهات

- تقريبا جميع النساء معرضات الى الاضطرابات النفسية خلال فترة الحمل وخلال السنة الأولى بعد الولادة، لكن اهم عوامل الخطورة تتضمن
- الوضع الاقتصادي الاجتماعي المنخفض,
- عنف الزوج او سوء العلاقة الاسرية,
- الإجهاد البدني والنفسي الشديد،
- تاريخ من المشاكل في الصحة النفسية,
- سوء حالة الصحة الانجابية,
- حالات الطوارئ والنزاعات والكوارث الطبيعية،
- انخفاض الدعم الاسري والاجتماعي.

عوامل الوقاية للاضطرابات النفسية للامهات

- تجنب عوامل الخطورة, التعليم، العمل وتمكين المراة، علاقة الزوج الحسنة, والرعاية الصحية المباشرة للمعرضات للخطورة.

الاستجابات

- تقييم وإدارة الاضطرابات النفسية النفاسية يتم من خلال ادماج خدمات الصحة النفسية ضمن خدمات رعاية الام والطفل
- ان الاضطرابات النفسية للأمهات يمكن تقيمها وتدبيرها من قبل مقدمي الرعاية الصحية غير المتخصصين والمدربين تدريبا جيدا
- يوفر الدليل التدخل الفجوة في الصحة النفسية المبادئ التوجيهية بشأن تحديد وإدارة الاضطرابات النفسية من قبل مقدمي الرعاية الصحية النفسية غير المتخصصة بما في ذلك النساء الحوامل وبعد الولادة.

الاضطرابات النفسية للمراة

١- الاضطرابات النفسية الخاصة بالدورة الشهرية

أ- الحيض: تصاحبها حالات الخوف والقلق والتوتر حين لاتكون الانثى مهيأة نفسيا لذلك.

قد يضطرب الحيض بالتقدم والتأخير اوالتكرار اوالتوقف او القلة، ويصاحبه عادة اويسبقه بعض الاعراض المرضية في المجال النفسي والجسمي تتصف بالكآبة والتوتر وسرعة الانفعال كما تظهر بعض الاعراض الجسمية كالصداع والتشنجات العضلية والالام العامة في المفاصل والاطراف وهو مايسمى**(بالتوتر السابق للحيض)**

من الحالات الشائعة بين النساء **توقف الدورة كليا** وهذه الحالة قد تحدث في مرض الكآبة بشكل خاص ويكون الرجوع الدورة اهم دليل على قرب **زوال الكآبة**.

ب- سن ما بعد الأنجاب (سن توقف الحيض والأنجاب):

- ان توقف الحيض والانجاب Menopause قد تصاحبه أعراض اكتئابية،
- ان استعمال مصطلح (سن اليأس) يفهم خطأ فيعتبر يأساً في المجال النفسي والأجتماعي وهذا غير صحيح.
- علمياً (سن الياس) يعني اليأس من الحيض وتوقف القدرة على الأنجاب ولايعني توقف المزايا الأخرى للمرأة كأنثى.

٢ - الاضطرابات الخاصة بالحمل والانجاب

أ-العقم:

ان القدرة على الحمل في المرأة تعتمد في الاساس على عملية انماء واصدار البويضة من المبيض الى الرحم ،وهذه تعتمد بدورها على العمليات الهرمونية اللازمة الخاصة بذلك . وهذه العمليات تتاثر بالعمليات العقلية في المراكز العصبية العليا في الدماغ وان من الممكن للانفعالات العاطفية مثل القلق او الخوف ان تاثر في هذه المراكز العصبية وبالتالي تؤثر في الافرازات الهرمونية التي تؤثر في النهاية على عمل المبيض.

ب- منع الحمل:

ان احتمال حصول حمل من عملية جنسية واحدة في افضل فترات الاخصاب لاتتعدى٢٥% ، ولكن الاحصائيات الغربية بينت حوالي ثلث الولادات المسجلة ناتجة عن حمل غير مرغوب فيه ، بسبب فشل طرق منع الحمل المتبعة. وهذا يكون له تاثير سلبي على الحالة النفسية للام ثم على نفسية الطفل. كما ان عدم اعتماد طريقة ناجحة لمنع الحمل وتخطيط الانجاب قد يشير الى اضطراب عام في نظام العائلة وعلاقاتها.

ت - الإجهاض وفقدان الحمل:

يزداد احتمال حصول الاضطرابات النفسية بعد الإجهاض في الحالات التالية:

- وجود تاريخ مرضي نفسي قبل الإجهاض.
- إذا كان قرار الإجهاض غير مخطط له من قبل الزوجين ومصحوب بتردد.
- اذا كان اكتشاف الحمل مصحوبا بشعور شديد القلق ولم يتدخل الزوج في الموضوع الحمل وكأنه لايعنيه.
- في حالات الإجهاض المتكرر.

المضاعفات النفسية:

- تشعر المرأة بالذنب لأنها أجهضت طفلها.
- قد تفقد احترامها لنفسها لأنها لاتستطيع الاعتماد على جسدها لتنجب طفلا.
- مشاعر الخسارة والحزن والفراغ العاطفي والغضب والغيرة.

٣- اضطرابات مابعد الولادة

أ- غم الولادة (غم الأمومة) Maternal Blues

إن نسبة حصول هذه الحالة هو حوالي ٥٠% (أي نصف حالات الولادة) وتزداد في الولادات الأولى وخاصة إذا كانت إلام تشكو أصلا من التوتر السابق للحيض وهو اضطراب مؤقت في بالمزاج ويتميز بالشعور بالاكتئاب وعدم الاستقرار وشعور إلام بأنها بعيدة عن الطفل ويرافق ذلك ارق وصداع وضعف التركيز.

- تبدأ الحالة في الأسبوع الأول من الولادة عادة وتستغرق (٢-٣) أيام.
- أسبابها مزيج من أسباب نفسية وأسباب كيميائية حياتية.
- علاجها فهو:
  - ✓ الاهتمام بحاجة الام إلى الراحة والتغذية وضرورة التحدث عن مشاعرها.
  - ✓ إخبار العائلة بأنها حالة مؤقتة, وان رعاية الطفل مسؤولية مشتركة وخبرة ممتعة.
  - ✓ مراقبة إلام وتطمينها وإسنادها ودعمها نفسيا.
  - ✓ أعطاء النصائح لها حول إرضاع الطفل ورعايته.

ب. اكتئاب مابعد الولادة Postnatal Depression

نسبة حصوله هي ١٠% (حالة واحدة لكل ١٠ ولادات).وهو أشبه بالكآبة الانفعالية التي تحدث في الظروف والأوقات الأخرى غير المرتبطة بالولادة.

- تبدأ الحالة في الأسبوع الثاني أو الثالث بعد الولادة عادة وتستغرق ٤-٦ أسابيع.
- أسباب الحالة هي تفاعل الأسباب الحياتية مع الأسباب النفس/ اجتماعية (كما في حالات حدوث الولادة مع عدم توفر السند الاجتماعي الكافي) ويزداد حصول الحالة لدى الأمهات ذوات الشخصية العصابية Neurotic personality، والأمهات اللواتي كن يعانين من العلاقة الصعبة مع الوالدين أثناء مرحلة الطفولة.
- تتميز أعراض الحالة بشعور بالأكتئاب مع فترات من الميل للبكاء وعدم الاستقرار والشعور بالتعب والإنهاك والإحساس بعدم الكفاءة لتلبية حاجات الطفل ويصاحبها ضعف في الشهية والتركيز والرغبة الجنسية.

وتعالج الحالة كما يلي:

أولاً: الطرق الإسنادية العامة كالتشجيع والشرح والتطمين.

ثانياً: العلاج بالأدوية المضادة للقلق والكآبة.

ثالثاً: العلاج النفسي الزواجي Marital therapy

المآل:Prognosis: حوالي ٩٠% منها تنتهي في أقل من شهروحوالي ٤% تتحسن خلال سنة.

ج. ذهان النفاس: Puerperal Psychosis

- يحصل بنسبة حالة واحدة من كل ٥٠٠ حالة ولادة (أي بنسبة ٢ لكل ألف ولادة).
- تظهر أعراضها عادة في الأسبوع الثاني أو الثالث بعد الولادة.
- تحتاج الى ٦-١٢ أسبوعاً لكي تختفي أعراضها.
- اسباب المرض تعزى لعوامل وراثية وعوامل حياتية إضافة إلى العامل النفسي المصاحب للولادة.
- إحتمال حصول الحالة في الولادات اللاحقة يرتفع ليصل الى ٢٠% من الولادات اللاحقة (خمس الولادات).
- أعراض المرض
  - تبدأ بالأرق وعدم الأستقرار وتتطور الى تشوش الوعي مع حيرة

- قد يصاحبها أوهام Delusions
- هلاوس Hallucination
- غياب البصيرة insight Loss of
- إضافة الى ميول إنتحارية أو ميول لقتل الطفل.

العلاج:

- تحتاج معظم الحالات الى إدخال الأم إلى الردهات أو المستشفيات النفسية، وتفضل ردهة خاصة بالأم والطفل Mother and child unitللإبقاء تماس الأم بالطفل وتشجيع التماسك Bonding بينهما.
- ينصح بالرضاعة الطبيعية.
- تشجيع الأب ليكون حلقة الوصل بين الأم وبقية أفراد العائلة .
- استعمال الأدوية المضادة للذهان له دوره المهم في المعالجة.
- قد تحتاج بعض الحالات الشديدة إلى أستعمال الصدمة الكهربائية ECT والتي تعطي عادة أستجابة جيدة.

مآل المرض:

يحصل تحسن كامل في حوالي ٧٠% من الحالات مع احتمال معاودة الحالة في الولادات اللاحقة بنسبة ١٤-٢٠%.

العنف القائم على النوع الاجتماعي

كيفية اكتشاف حالات العنف والتعامل معها في مراكز الرعاية الصحية الاولية

الرعاية الصحية للناجية من العنف واجب (وظيفي, اخلاقي, قانوني, ديني, انساني) وتتم بالخطوات التالية:

- التشخيص
- الرعاية العاجلة (الطمأنة) (معالجة الاصابات الخطرة)
- الرعاية الصحية الاولية (فحص وتحري بدني شامل)(جمع الادلة العدلية) (الوقاية)
- الرعاية اللاحقة (تقييم الحالة النفسية والمعالجة)
- التوثيق

اولا: تشخيص حالة التعرض للعنف اوالاشتباه بها

تتم من قبل اطباء المركز او معاونيهم من خلال :

١. اجهار الضحية بالعنف (او ولي الأمر).

٢. وجود آثار جسدية: (جروح، رضوض, أنزفة، خدوش، كدمات، أورام، كسور، حروق)

٣. ملاحظة وجود مؤشرات نفسية او اجتماعية.

- ✓ ضعف التواصل بالنظر.
- ✓ خوف غير المبرر، اضطرابات النوم،
- ✓ اعراض اكتئآبية،
- ✓ افكار أو محاولات انتحارية.
- ✓ التدخين، تعاطي المخدرات.
- ✓ الحمل غير المرغوب فيه، الاجهاض,
- ✓ امراض منقولة جنسيا.
- ✓ مشكلات نفسية ناتجة من الخوف والتعاسة.
- ✓ آلام حادة بدون إصابة منظورة أو آلام مزمنة لا تفسير طبي لها.

- ✓ تراجع مستوى الأداء الحياتي أو الاجتماعي كالدراسة والعمل والعلاقات.

ثانيا: الرعاية العاجلة

تقدم الرعاية العاجلة في اللحظات المبكرة لاكتشاف حالة العنف:

- ✓ معالجة الحالات الطبية البدنية الطارئة.
- ✓ إشعار الضحية بالأمان والطمأنينة والحفاظ على السرية والخصوصية.
- ✓ استدعاء أفراد الأسرة إلذين يشعرون الضحية بالطمأنينة واالأمان.
- ✓ تتاح للضحية فرص الاتصال مع من تريد.
- ✓ ابداء الاستعداد لتقديم كل وسائل الرعاية الصحية البدنية والنفسية.
- ✓ تجنب لومها أو تأنيبها أو الضغط عليها بأي شكل من الأشكال.
- ✓ تجنب الموقف القيمي تجاهها وتكون داعم وإيجابي نحو الضحية.
- ✓ يستوجب طمأنتها بإتاحة الفرصة لنيل حقها القانوني.
- ✓ يجب ألاّ نثقل على الضحية بالأسئلة والسماح لها بالتحدث إن كانت راغبة.

ثالثا: الرعاية الأولية

فحص وتحري بدني شامل

- ✓ يتم الفحص من قبل طبيبة مدربة على التعامل مع حالات العنف، لصعوبة أن يتم الكشف من قبل طبيب أو أن يسألها أسئلة جارحة لأنوثتها. إذا كان هذا غير متاح فيتواجد مع الضحية كادر انثوي مدرب على التعامل مع حالات العنف .
- ✓ تقوم الطبيبة بفحص وتحري بدني شامل بعد اخذ الموافقة المستنيرة في كل خطوة اثناء الفحص لتقييم الحالة. ويتم الفحص في مكان يتسم بالخصوصية والهدوء والراحة.
- ✓ معالجة اي اصابات بدنية كالجروح والسحجات والكدمات والكسور ونزيف أو ما يهدد الحياة.
- ✓ التحفظ على عينات الدم والشعر والملابس وأي سوائل أخرى على جسد الضحية للمساعدة على لتعرف على الجاني وإثبات إدانته. وتوثيق الحالة والعلامات المادية والمشاهدات والمداخلات كافة بوضوح حتى القديمة منها وحسب سياقات التعامل مع قضايا الشرطة. (جمع الادلة العدلية)
- ✓ الاحالة الرصينة للمستشفى إن لزم الأمر.
- ✓ إذا لم تستطع الضحية الإدلاء بالتفاصيل في الجلسة الاولى, لا تجوز الضغط عليها وربما نحتاج لأكثر من جلسة لإتمام التقييم الطبي والنفسي.
- ✓ إبداء الاستعداد لمعالجة مرتكب العنف اذا كات يشكو من اضطراب نفسي.

الاجراءات الوقائية

- ✓ الوقاية من الحمل,
- ✓ الوقاية من الامراض المنقولة جنسيا

اعلام االناجية من العنف بالحقوق التالية:

- ✓ الحق في تلقي الخدمات الصحية
- ✓ الحق في السرية والخصوصية والموافقة المستنيرة
- ✓ الحق في الكرامة الانسانية
- ✓ الحق في اقامة دعوى رسمية في الشرطة وبوجود مديرية خاصة للشرطة المجتمعية
- ✓ الحق في طلب الحماية القانونية بوجود مديرية حماية الأسرة

- ✓ الاستفادة من الخدمات المجتمعية والقانونية التي تقدمها بعض منظمات المجتمع المدني الموجودة في المنطقة.

رابعا: الرعاية اللاحقة

الهدف: تقييم الحالة النفسية للضحية ومعالجة المشاكل النفسية الممكنة. تتابع الحالة في وحدة الصحة النفس– اجتماعية في المركز الصحي وقد تحتاج الى عام كامل من المتابعة لتتكيف مع الحالة وتستعيد حياتها الطبيعية.

- ✓ تقديم خدمة المشاورة والارشاد والدعم النفسي للضحية (جلسات فردية او جماعية) والاتفاق على خطة المتابعة.
- ✓ مجاميع المساعدة الذاتية: هي مجموعة علاجية يقوم بها ناجيات من العنف سابقا او من لديهم الرغبة في المساعدة.
- ✓ يمكن وصف العلاج الدوائي اللازم للقلق أوالاكتئاب ومشاكل قلة النوم. من قبل طبيب مدرب على دليل العلاج للامراض النفسية الشائعة mhGAP .
- ✓ احالة الناجية الى الطبيب النفسي الاختصاصي عند الحاجة.
- ✓ احالة الضحية الى المؤسسات الأسرية أو المنظمات المجتمعية لتلقي الرعاية الاجتماعية أو القانونية اللازمة إن أرادت ذلك.

خامسا: التوثيق

- ✓ يتم توثيق الحالات في سجل خدمات المشاورة والدعم النفسي.
- ✓ يتم ارسال تقرير شهري بالخدمات المقدمة في وحدة الصحة النفس اجتماعية الى دائرة الصحة.

اذا كانت الحالة اغتصاباً، فيجب اخبار الناجية بوجوب تأكيد وتوثيق الأضرار بالطرق القانونية والطبية العدلية وإرشادها الى كيفية عمل ذلك.

الحالات التي يفترض ان تحال الى وحدات الصحة النفس اجتماعية

تتم الاحالة بعد اقناع المراجعة بضرورة احالتها لتلقي التدبير اللازم:

- ➢ المرأة التي تعاني اضطرابات نفسية.
- ➢ المرأة التي تعاني شكاوي جسدية مزمنة ليس لها تفسير.
- ➢ المرأة التي تشكو من أضطرابات في النوم.
- ➢ المرأة التي تشكو من حالات ادمان.
- ➢ المرأة التي فكرت أوالتي حاولت الانتحار.
- ➢ المرأة التي تشكو من مشكلات نسائية متكررة.
- ➢ المرأة التي يبالغ الشريك في مراقبتها أو اخافتها.
- ➢ حالات العقم والحمل غير المرغوب به والاجهاض المتكرر.
- ➢ اضطرابات مابعد الولادة (غم الولادة, اكتئاب مابعد الولادة, او الذهان).
- ➢ الامراض المنقولة جنسيا والتهاب الكبد الفايروسي بي وسي.
- ➢ حالات العنف الاسري المصرح بها او تلك التي يستدل عليها من خلال وجود آثار جسدية أو وجود مؤشرات نفسية او اجتماعية.

الفصل الرابع

الصحة النفسية لكبار السن

حقائق اساسية عن الشيخوخة:

- سكان العالم يهرمون بسرعة حيث ستتجاوز نسبتهم ٢٢% عام ٢٠٥٠.
- أهمّ الأعباء الصحية التي يتحمّلها المسنون تنجم عن الأمراض غير الانتقالية ومنها الاضطرابات النفسية.
- أهم أسباب إصابتهم بالعجزهي ضعف البصر والخرف والكأبة وفقدان السمع والفصال العظمي.
- ان العلل البدنية أو العجز لديهم هي من الاسباب الرئيسية لخطر الإصابة بالاضطرابات النفسية اوعصبية أو مشاكل تعاطي المخدرات وان وصمة العار التي تحيط بالاضطرابات النفسية تجعل الناس يترددون في طلب المساعدة.
- هم بحاجة الى توفير الرعاية الصحية الأولية بفعالية, وحاجتهم إلى رعاية طويلة الأجل في تزايد(التمريض المنزلي , الرعاية المجتمعية, رعاية مراكز المسنين والمستشفيات).
- الإعداد للتمتع بالصحة في مرحلة الشيخوخة يبدأ في مراحل مبكّرة من العمر يشمل (الغذاء الصحي, النشاط البدني المتواصل, عدم التعرّض للمخاطر الصحية مثل التدخين وتعاطي الكحول اوالمواد السامة).
- ضرورة توفير بيئات مادية واجتماعية داعمة للمسنين تحفظ استقلاليتهم ونشاط فاعل.

عوامل الخطورة للصحة النفسية لدى المسنين

- فقدان القدرة على العيش بصورة مستقلة بسبب محدودية الحركة، أو الألم المزمن، أو الضعف والوهن.
- التراجع في نشاط الحواس خاصة النظر والسمع.
- انخفاض الوضع الاجتماعي والاقتصادي حيث يؤدي إلى العزلة وفقد الاستقلال والشعور بالوحدة والضيق النفسي لديهم
- إلإهمال البدني وسوء المعاملة والتي تؤدي ليس إلى مجرد إصابات بدنية بل إلى اضطرابات نفسية خطيرة وطويلة الأمد بما في ذلك الاكتئاب والقلق.
- الصحة البدنية تؤثرعلى الصحة النفسية والعكس بالعكس (مثلا اللذين يعانون من أمراض القلب لديهم معدلات اكتئاب أعلى من السليمين, كما وان عدم معالجة الاكتئاب لدى شخص مسن مصاب بمرض القلب يؤثر سلباً على نتيجة المرض البدني).
- إلمسنين هم أكثر عرضة لاضطراب المشاعر كالحزن والحداد.

معظم كبار السن يتحلون بالصحة النفسية لكن ١٥% منهم فقط يعانون من الاضطرابات النفسية, وان اكثر الاضطرابات النفسية شيوعا بينهم هي:

- الخرف ويصيب من ٥-٨% منهم.
- الكأبة ويصيب حوالي ٧% منهم.
- القلق ويصيب ٥% منهم.
- سوء استخدام المواد ويصيب ١% منهم.
- الانتحار (٢٥% من كل حالات الانتحار تقع بينهم).

اولا: الخرف:

هو متلازمة تتسم بحدوث تدهورتدريجي في الذاكرة والتفكير والسلوك مع إضطراب الإدراك للزمان والمكان والأشخاص يصاحبها تغير في الشخصية وتدني القدرة على أداء الأنشطة اليومية (بوتيرة تتجاوزالتدهور المتوقّعة في مرحلة الشيخوخة

العادية مع ظهور بعض الهلاوس والأوهام ويتعرض المريض بين وقت وأخر إلى حالة هذيان شديدة أو خفيفة قد تطول أو تقصر). وتتراوح أعراض الخرف من النسيان البسيط الى القيام ببعض التصرفات الشاذة كوضع الملابس القذرة في الثلاجة إو خروج المريض للشارع تائهاً لايعرف مكانه وزمانه. علما ان الخرف ليس جزءاً طبيعياً من التشيخ لكنه يصيب بشكل رئيسي الاشخاص المسنين, وأهم اسبابه:

أ- تنكسية مثل داء الزهايمر.
ب- وعائية كالنزف تحت السحايا أو أحتشاءات في الدماغ.
ت- التهابات الجهاز العصبي المركزي ومنها السفلس والإيدز ومرض جنون البقر.
ث- التصلب المنتشر
ج- إضطرابات الغدد الصماء مثل قلة إفراز الغدة الدرقية.
ح- أمراض أخرى مثل داء الرقص والشلل الأهتزازي

التدخلات:

معظم حالات الخرف مزمنة ولايوجد دواء نوعي شاف لها, ولكن لابد من الفحص والتأكد من وجود بعض الأسباب المرضية التي تسبب تدهور القدرات الذهنية المشابه للخرف والتي يمكن علاجها إذا شخصت مبكراً مثل أستسقاء الدماغ الذي يعالج جراحياً, أو حالات قلة إفراز الغدة الدرقية أو نقص فيتامين ب١٢والنياسين أو السفلس.

اما على مستوى الرعاية الصحية الأولية فمن المهم جداً توعية ذوي المريض وإرشادهم في كيفية التعامل معه وتقديم العناية التمريضية والإجتماعية المناسبة ومراجعة الطبيب عند حصول طوارئ كالهذيان.

ثانياً: الكأبة

هو اضطراب وجداني (عاطفي) (مزاجي) يمتاز باعتلال الحاله المزاجية (الشعور الدائم بالحزن)، وفقدان الاهتمام والاستمتاع بفعاليات الحياة اليومية وعدم الشعور بلذة الحياة، وانخفاض الطاقة والتعب السريع مما يؤدي إلى تقلص النشاط اليومي ولمدة اسبوعان على الأقل, وكثير ممن يعانون من الاكتئاب ترافقهم أعراض اضطرابات القلق واعراض جسدية غير مبررة طبيا.تصنف الكأبة الى نوعين رئيسيين (كأبة عصابة, وكأبة ذهانية).

التداخلات:

لا توجد طريقة علاجية واحدة أو عقار واحد يضمن الشفاء لجميع المرضى وقد تختلف استجابات المرضى للعلاج حتى في الحالات المتشابهة، وقد يحتاج الطبيب للجمع بين أكثر من طريقة في آن واحد ويعتمد هذا على خبرته الشخصية وحالة المريض واستجابته.

تعالج معظم الحالات في العيادة الخارجية ولكن يجب إدخال المريض للمستشفى لحمايته وحماية الآخرين وتقليل معاناته في الحالات التالية:

- التفكير بالانتحار أو محاولته فعلاً الانتحار.
- تدهور الصحة العامة للمريض أو امتناعه عن تناول الطعام.
- إذا كانت ظروف المريض العائلية غير مناسبة.

إن أعراض الاكتئاب لدى كبار السن غالباً ما يتم التغاضي عنها وعدم معالجتها لأنها تتزامن مع امراض بدنية. وتفسر على انها أعراض طبيعية ناجمة عن تقدم السن, وقد تختلف اعراض الاكتئاب في هذه الفئة العمرية عن الفئات العمرية الاخرى حيث يبرز التركيز على الموت والرغبة به ووجود الالام الجسدية كالالام المفاصل والصداع اكثر من الحزن.

اساليب العلاج:

أ- الصدمة الكهربائية ECT، وهي أكثر فائدة في الحالات المتقدمة جدا عندما يصبح المريض خطراً على نفسه أو على الآخرين ولايستجيب للعلاجات الأخرى وخاصة في وجود افكار انتحارية.

ب- العقاقير المضادة للكآبة: وهي(التربنزول, التوفرانيل والفلوكستين), ويجب أن تعطى العقاقير بجرعة بسيطة ثم تزاد تدريجياً وحسب استجابة المريض وعمره.

ت- العلاج النفسي: ويهدف إلى تقديم الإسناد المعنوي عن طريق التعاطف والتقدير والاهتمام بمساعدة المريض على كسب تقدير نفسه واستعادة ثقته بها وزرع الأمل بالشفاء وبيان الجوانب الأيجابية في حياته والابتعاد عن الأفكار السلبية. وهذا العلاج مهم كثيراً لحالات الكآبة البسيطة.

ث- العلاج الأجتماعي: ويتضمن البحث عن الأسباب الاجتماعية كالمشاكل العائلية والزوجية والعزلة الاجتماعية والبطالة والمشاكل المالية التي أدت إلى حدوث الكآبة ومساعدة المريض على تفهم ومعالجة هذه الأسباب، وفي حالة عدم القدرة على التغيير ومعالجة هذه الأسباب الاجتماعية فعلى المريض أن يتكيف ويتأقلم معها.

ج- في حالات الكآبة الشديدة يتفق معظم الاطباء على ضرورة تناول العقاقير المضادة للكآبة لفترة ستة أشهر بعد الشفاء لمنع تكرار وقوعها ويجب تقليل الجرعة بصورة تدريجية على مدى ١-٢ شهر منعاً لظهور الأعراض الأنسحابية للعلاج.

ثالثا: اضطرابات القلق

هي فئة من الاضطرابات النفسية التي تتميز بمشاعر القلق والخوف ، القلق من احداث المستقبل والخوف كأستجابة لحداث جارية. والفرق الرئيسي بين اضطرابات القلق والمخاوف العادية هي في الشدة الاعراض والقدرة على الاداء الوظيفي والمجتمعي.

ويمكن تحديد حالات القلق إذا اشتكى المريض من أحد الأعراض التالية لعدة أيام في الشهر ولمعظم ألاشهر:

- الشعور المستمر بالخوف من دون سبب واضح.
- الشعور المستمر من التوتر وعدم الاستقرار وعدم القدرة على التركيز .
- الاستجابة المفرطة للمؤثرات الخارجية .
- اضطراب في النوم أو اضطراب في الأكل: (زيادة في تناول الطعام او بالعكس).
- اعراض جسدية المختلفة مثل: الصداع ، والتعب، وألم في الصدر وضيق في التنفس واعراض الجهاز الهضمي.
- العزلة الاجتماعية : ناتجة من فقد علاقاتهم مع العائلة والأصدقاء.
- استخدام الكحول وغيرها من المواد (قانونية أو غير قانونية).

التداخلات:

هي نفسية بالدرجة الأولى؛ بتطمين المريض وارشاده لحل مشاكله الخاصة بشكل مناسب، مع ممارسة تمارين الأسترخاء والسيطرة على التنفس. وقد نستعمل (لدورات قصيرة) العقاقير المضادة للقلق مثل الديازيبام (الفاليوم) أو كلوردايزيبوكساييد (الليبريوم) على ان لا تزيد الفترة عن اسبوعين واذا احتاج المريض لفترة أطول من العلاج فتجب إحالته إلى طبيب نفسي.

رابعاً: سوء استخدام العقاقير

يعرف سوء إستخدام العقاقير بتناول العقاقير الممنوعة قانوناً أوالوصفات الطبية عندما يتناول الشخص العقار بطريقة أوبكمية مخالفة للوصفة الطبية أو لسبب غير قانونى. و قد يؤدى سوء إستخدام العقاقير إلى الإدمان وكل هذه العقاقير تسبب اضراراً صحية بليغة وهذه الأضرار أما بدنية أو عقلية أو اضرار في الأداء الاجتماعي.

يستخدم بعض الناس المخدرات كوسيلة للتخفيف من الضغوط النفسية و العاطفية كالشعور بالتوتر، القلق، الأرق، الغضب، الملل أو الإكتئاب وقد يستخدم آخرون المخدرات لتغزيز ثقتهم بالنفس عند مواجهة الضعوط النفسية. قد يستخدم البعض العقار لأول مرة ثم يداوم على إستخدامه لشعوره بالمتعة الناتجة من تأثيره عليه كالشعور بالنشوة، الإسترخاء، التخلص من الألم، التخلص من القلق والتوتر وأحياناً القدرة على البقاء متنبهاً لفترات طويلة. ويستخدم البعض

العقاقير لآنهم أصبحوا معتمدين عليها نفسياً و جسدياً وذلك بصرف النظر عن قوة العقار أو ضعفه أو ما إذا كان العقار يستخدم فى أغراض طبية أو غير قانونية.

الإدمان هو مجموعة ظواهر فسيولوجية وسلوكية ومعرفية حيث يعتبر تعاطي المادة من ألاولويات العليا لشخص على بقية الاشياء حيث ان عدم تناول المادة بعد الاستعمال اليومي ولفترة طويلة يؤدي الى ظهور مجموعة من الأعراض الشديدة تسمى بالاعراض الانسحابية.

علامات الادمان:

- الاعتماد الكلي عليها والرغبة القوية والملحة على تعاطي المادة.
- صعوبات السيطرة في تعاطيها من حيث (بدايتها أوإنهاءها أو مستويات الاستخدام)
- طلب متزايد من الجرعات من أجل تحقيق تأثيرات كان ينتج بواسطة جرعات اقل.
- الخوف من أعراض الانسحابية وعدم القدرة على تخفيف أو تجنب تعاطيها.

التدخلات :

يجب اجراء مجموعة من الفحوصات وهي (فحص البول للمادة المخدرة وهي وسيلة مفيدة للتحقق من تاريخ تعاطي المخدرات، وخاصة إذا كان الشخص لا يقول الحقيقة, واجراء فحص الدم السيرولوجي للبحث عن الفيروسات التي تنتقل عن طريق الدم (فيروس نقص المناعة البشرية والتهاب الكبد سي والبي, اختبارات الأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي (STI), واختبار البلغم (عند الاشتباه السل).

- تلبية احتياجات السكن و دعم الأسري والمجتمعي
- تقنيات التدخل البسيطة للكشف وتحديد مستوى الادمان
- استراتيجيات الحد من الضرر باعطاء مضادات المواد الأفيونية
- استمرار العلاج والدعم النفسي بعد إزالة السموم
- المساعدة الذاتية للجماعات

خامسا: الانتحار

هو الفعل الذي يتضمن تسبب الشخص عمداً في موت نفسه.

أن العلاقة قوية بين الانتحار والاضطرابات النفسية (خاصة الاكتئاب والاضطرابات الناجمة عن تعاطي الكحول)، إلا أن هناك العديد من حالات الانتحار التي تحدث فجأة في لحظات الأزمة نتيجة انهيار قدرة الفرد على التعامل مع ضغوط الحياة، مثل المشاكل المالية، أو انهيار علاقة ما أو غيرها من الألآم والأمراض المزمنة., بالإضافة إلى ذلك، تقترن النزاعات والكوارث والعنف وسوء المعاملة أو الفقدان والشعور بالعزلة بقوة بالسلوك الانتحاري. وتعتبر محاولة الانتحار السابقة أقوى عامل خطر للانتحار.

غالباً، تكون هناك مؤشرات تدل على إحتمال إقدام الفرد على الإنتحار وتزداد أهمية وخطورة هذه المؤشرات لدى كبار السن المنعزلين واللذين يعانون من الوحدة واهمها هي:

أ- مؤشرات لفظية: بأن يتحدث الفرد عن الرغبة في إنهاء حياته أوينطق بأفكار إنتحارية غير مباشرة. (مثلاً: الحياة لاتستحق أن نعيشها، أو أن الراحة الوحيدة هي في الموت).

ب- مؤشرات سلوكية: كتناول جرعة بسيطة من مادة مميتة أو توزيع ممتلكاته على الآخرين أو وضع خطة لذلك.

ت- مؤشرات وضعية: وذلك بتعرض الفرد إلى كروب أو ضغوط نفسية أو صدمات كالإصابة بمرض خطير أو فقدان شخص عزيز أو الفصل من العمل.

ث- مؤشرات إضطراب نفسي: الكآبة من الأمراض التي تعرض المصاب إلى الإنتحار وكذلك الهذيان والإضطراب الذهاني الإضطهادي تحت تأثير الأوهام وكذلك في حالات الرغبة في التحدي.

التدخلات:

- أخذ التاريخ المرضي والإجتماعي والعائلي بدقة وملاحظة وجود أي مؤشر سابق للانتحار.
- فحص الحالة النفسية والتحري عن بعض الأعراض المرضية المهمة كالشعور بأنه منبوذ وغير نافع أو عالة على الأخرين.
- التحري عن الإصابة بأمراض مزمنة ومعوقة ومؤلمة أو خطرة ومميتة وبالأخص التي يرافقها إضطراب النوم المزمن وعن اللجوء إلى سوء إستخدام الكحول والمواد الكيمياوية للتخفيف عن معاناته.
- يجب أدخال المريض المستشفى إذا كانت رغبته في الأنتحار شديدة أو إذا لم يوجد من يحمي المريض ويرعى حالته النفسية والصحية أو أنه بدون مأوى أمن او انه من الذين يتسمون بالإندفاع والتحدي أو المخاطرة, وعند وضعه في المستشفى ينبغي إبعاد كل مايمكن أن يستخدمه لتنفيذ المحاولة الإنتحارية كالعقاقير والالات الحادة والمكان العالي أو المصادر الكهربائية ويتعين أن يكون تحت مراقبة دقيقة مستمرة.
- معالجة الإضطراب النفسي الأساسي كالكآبة أوالفصام وإستخدام العلاج النفسي الإسنادي والتوجيه والعلاج المعرفي ومساعدته في إيجاد الحلول لمعضلاته الإجتماعية والإقتصادية والعائلية. وعند وصف العقاقير ينبغي عدم وصف تلك التي عند أخذها بجرعات عالية تشكل خطورة على حياة المريض، كما ويجب إعطاؤه كميات صغيرة منها ويفضل أن يكون تناول الدواء بإشراف أحد ذويه. ويمكن إستخدام الصدمات الكهربائية في المعالجة إذا استدعى الوضع ذلك.

المشاورة والدعم النفسي ومهارات التواصل

ان المشاورة هي عملية علاجية علمية، هادفة، ومرتبة تتضمن محادثة سرية بين المشاور(المرشد) النفسي. وبين المراجع (المستفيد). و تهدف الى مساعدة المراجع وبالتعاون معه على استكشاف وتحليل مشاكل، أفكار، وعواطف، وامكانيات المُراجع وتحديد موارد الدعم والإسناد والمساعدة المتيسرة له والتي يمكن أن يستفيد منها لتجاوز الصعوبات التي يمر بها وليعيش في أحسن حال ممكن بالنسبة له من خلال إعادة ترتيب أفكاره لتحديد أبعاد مشكلته بوضوح ودراسة الحلول أو أساليب التعامل الممكنة معها واختيار الأسلوب الأفضل له. وعادة يحتاج المستفيد ٦ الى ٨ جلسات للوصول للنتيجة المتوخاة. ان تقديم المشاورة والدعم النفسي لكبار السن موضوع في غاية الاهمية وان هذه الخدمة تقديم أما لهم مباشرة او من خلال القائمين على رعايتهم. وأن مهارت المشاورة تزداد وتتطور في التطبيق وتكرار الممارسة, من العوامل المهمة التي تعين الملاكات الطبية والصحية على النجاح في عملها هي القدرة والامكانية على إقامة علاقة جيدة ناجحة مع المراجع وخاصة كبار السن، فمثل هذه العلاقة تساعد في الوصول الى التشخيص الصحيح للمشكلة ووضع خطة الحل المناسب, كما وتزيد هذه العلاقة الجيدة من ثقة المراجع وقناعته بالعامل الصحي؛ وهذا بدوره سيزيد من ثقة العامل الصحي بنفسه واحترامه لذاته, والتواصل بكل بساطة يعني عملية نقل المعلومات او الأفكار (الرسائل) من ذهن الفرد الأول (ويسمى المرسل) الى ذهن الفرد الثاني (يسمى المستقبل) وبالعكس حيث يتم تبادل هذه الرسائل بينهما للوصول الى فهم مشترك للموضوع المبحوث. **ان** الاتصال عموماً نوعان:

١. الاتصال اللفظي: أي المعلومات التي يتم تبادلها كلامياً (المنطوقة أو المكتوبة).
٢. الاتصال غير اللفظي: ويشمل كل المعلومات المتبادلة باستعمال الإيماءات والحركات وتعابير الوجه وما شابه (لغة الجسد). وهذا النوع مهم جداً وكثيراً ما يوصل الرسالة بشكل أكثر وضوحاً ومصداقية, والاتصال غير اللفظي يعتمد على نوعين من التعابير او المؤشرات(المؤشرات الثابتة: مثل الشكل او المظهر كالطول او القصر، الملابس، ارتداء الحلي او المجوهرات، المكياج, والمؤشرات المتغيرة (الحركية): مثل وضعية الجسم وحركاته، النظر في العينين، تعابير الوجه، طريقة الكلام والصوت ونغمته).

وعند التعامل مع المريض تذكر أن أبعاد الصحة النفسية هي (الأفكار، المشاعر، والسلوك), وفيما يلي ايجاز لاسس المقابلة والدعم النفسي.

١. عرف المستفيد بنفسك وطَمئِنهُ بأنك ستعمل لمساعدته.
٢. يجب اظهار الاحترام الحقيقي للمستفيد (أياً كان). ويستحسن ان يجلس المراجع بجانب المشاور وليس أمامه لكي

لا تبدو المقابلة وكأنها تحقيق واستجواب.

٣. احرص على التواصل الودي المريح بالنظر، فالنظر في عيني المراجع كبير السن منذ البداية بود يعبر عن احترامه واهتمامه به.
٤. لاتنشغل بأي شيئ عندما يتكلم, وعلى المشاور أجادة الأصغاء ويكون حساس لاي لمحات العاطفية وكل مايدلل على الحالة النفسية للمراجع.
٥. التزم الهدوء والأسترخاء وبكل مايطمئن المستفيد ولا تتحرك بسرعة ولا تتحدث بعصبية ولا يتصرف بطريقة سلطوية متعالية.
٦. استأذن من المستفيد للموافقة على بدء المقابلة، وأكد له أن المعلومات ستبقى سرية ولن يطلع عليها أحد, وأستوضح شكوى المراجع بصورة جيدة.
٧. إبدأ بموضوع عام عن حالة المستفيد وأطرح سؤالاً مفتوحاً جوابها (نعم) أو (لا), وليس سؤالاً مغلقاً؛ لكي تساعده على الاسترسال بالحديث واستعمل مفردات لغوية بسيطة ومفهومة ويتجنب المصطلحات العلمية المعقدة.
٨. كن متعاطفاً مع المستفيد أي تفهم وتصور كيف يشعر المرء اذا مر بمثل الموقف الذي مر به المراجع وأظهر تشاعرك (تعاطفك) له، ولكن لا تكن عطوفاً ولا تنجرف بمشاعرك نحوه فتحزن انت ايضاً لحزنه أو تغضب لغضبه، او تكره معه.
٩. استخدم الايحاءات والإيماءات والاستجابات التي تظهر للمستفيد إهتمامك به وبأنك مصغ له وتمنحه الوقت اللازم.
١٠. وفر للمستفيد فرصة التحدث بدون وجود أحد من أهله، كما حاول أيضاً أن تتحدث مع الأقارب عند الحاجة, وكن قادرا على المداخلة السائدة أثناء تحدث المراجع وتستطيع إيقافه بصورة ايجابية إذا استدعى الأمر ذلك.
١١. فكر بأمعان بما يقوله المستفيد وأعد ذكره له بأيجاز؛ لتتأكد من صحة فهمك لما يعانيه, وانحني قليلاً باتجاه المُراجع من وقت لآخر لإشعاره بالأمان والألفة والمشاركة, واستخدم الإيماءات والاستجابات التي تظهر الاهتمام وتشجع التواصل.
١٢. تجنب الاستنتاجات السريعة واستخدام الكلمات أو الآراء التي تبدو وكأنها تعني أحكاماً.
١٣. لا يجوز التقليل من قيمة وأهمية أي شكوى مهما كان رأينا الشخصي بها. ولايجوز أن نطلب منه كبت مشاعره (مثلاً: لاتبكِ، استرخِ قليلاً، أو إهدأ لنتفاهم), بل نبين له تفهمنا وتقديرنا لمشاعره وله الحرية في التعبير عنها. اذا لاحظت على المراجع علامات القلق والتوتر فقدم له بعض اساليب الاسترخاء (مثلا تمارين التنفس ، التخيل)
١٤. استكشف مصادر الدعم المتيسرة للمستفيد (مثل العائلة، الأصدقاء، العمل، الدراسة، المواهب، المساعدات القانونية، المساعدات الاجتماعية) ثم يتدارس معه امكانية الاستفادة العملية منها.
١٥. اذا لاحظت على المراجع علامات الكأبة فحاول القيام بتنشيط سلوكي (مثلا: تشجيعه على الخروج لنزهة، زيارة الاقرباء، التسوق، ممارسة الرياضة، القراءة، الاستماع الى الموسيقى ...الخ)
١٦. اذا كان المراجع يعاني من اثار صدمة نفسية فلا تنسى ان تساعدة وتشجعه على الحديث عن ذكريات الحادث المؤلم ولكن بدون الضغط عليه بالحديث
١٧. اذا وجدت لدى المراجع افكارا انتحارية ،او انه حاول الانتحار فعلا فيجب عليك تبليغ اهله فورا او احالته الى طبيب نفسي.
١٨. سجل الملاحظات المهمة للعودة لها عند الحاجة.
١٩. حدد موعد جلسة المشاورة القادمة, وحين يخرج المراجع من عندك، دعه يشعر بانك قد سعيت بما تستطيع لمساعدته في حل مشكلته.
٢٠. حين تقدم خدمة المشاورة والأرشاد النفسي فتذكر:
   - ان تجزئة المشكلة لعدة مشاكل أصغر يساعد في تيسير حلها، ويفضل البدء بحل المشكلة الأهم بالنسبة للمستفيد.
   - ساعده على اكتشاف مصادر الدعم المتيسرة والبحث عن الحلول والبدائل الممكنة وبالاستفادة من الموارد المتيسرة.
   - انك لا تقرر الحل لمشكلة المراجع وانما تساعده لإعادة ترتيب أفكاره بشكل منتظم ليختار الحل الأنسب له.